单位代码： 10680　　分类号： R246.1

学　　号： 20182374　　密　级： 公开

雲南中醫藥大學

YUNNAN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

硕 士 学 位 论 文

舌针联合言语康复训练治疗中风后运动性失语的临床研究

Clinical study of tongue acupuncture combined with language rehabilitation training in the treatment of motor aphasia after stroke

培 养 单 位　第二临床医学院

研究生姓名　范梦蝶

学科、专业　针灸推拿学

研 究 方 向　针灸治疗心身疾病的临床研究

学 位 类 型　专业学位

指 导 教 师　王祖红主任医师

二〇二一年六月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

中文摘要.....1
Abstract.....3
中英文缩略词对照表.....5
引　言.....6
正　文.....8
资料与方法.....8
1 研究资料.....8
1.1 病例来源.....8
1.2 病例选择.....8
1.3 纳入标准.....9
1.4 排除标准.....9
1.5 剔除标准与脱落标准.....10
2 研究方法.....10
2.1 病例的随机分组.....10
2.2 治疗方法.....10
2.2.1 基础治疗.....10
2.2.2 舌针组.....11
2.2.3 对照组.....12
2.2.4 疗程.....12
2.3 观察指标.....12
2.3.1 一般性指标.....12
2.3.2 观察指标.....12
2.3.3 综合疗效评定.....12
2.4 统计分析.....13
2.5 技术关键.....13
研究结果.....14
1 病例完成情况分析.....14
2 一般资料分析.....14
2.1 两组患者的基线资料比较.....14
3 观察指标分析.....17
3.1 两组患者治疗前后4项语言功能的评分比较.....17
3.1.1 两组患者治疗前后的复述评分比较.....17
3.1.2 两组患者治疗前后的谈话评分比较.....18
3.1.3 两组患者治疗前后的理解评分比较.....19
3.1.4 两组患者治疗前后的命名评分比较.....20
3.2 两组患者治疗前后BDAE的言语功能分级比较.....22
4 疗效评价.....23
5 安全性分析.....24
讨　论.....25
1 立题依据.....25

中国知网 https://www.cnki.net

2 祖国医学对中风后运动性失语的认识.....25
2.1 祖国医学对于病名的认识.....25
2.2 祖国医学对病因、病机的探讨.....26
3 现代医学对中风后运动性失语的认识.....26
3.1 中风后运动性失语的病因及恢复机理.....26
3.2 现代医学治疗现状.....27
4 选择舌针法的理论探讨.....27
4.1 舌与经络、脏腑的关系.....27
4.1.1 舌与经络的关系.....27
4.1.2 舌与脏腑的关系.....27
4.2 管氏舌针的基础内容.....28
4.2.1 舌穴分布的理论依据.....28
4.2.2 舌针作用机理探讨.....28
5 选择舌针的依据.....29
6 言语康复训练的益处.....30
7 管氏舌针与言语康复训练相结合的优势.....30
8 疗效分析.....31
8.1 两组患者治疗前后复述评分比较.....31
8.2 两组患者治疗前后谈话评分比较.....31
8.3 两组患者治疗前后理解评分比较.....31
8.4 两组患者治疗前后命名评分比较.....31
8.5 两组患者治疗前后的言语功能分级比较.....32
8.6 疗效评价.....32
结　论.....33
不足与展望.....34
参考文献.....35
文献综述.....38
针刺治疗中风后运动性失语的研究进展.....38
参考文献.....44
附　录.....48
附录一：.....48
附录二:.....51
致　谢.....52

中国知网 https://www.cnki.net

舌针联合言语康复训练治疗中风后运动性失语的临床研究

中文摘要

目的：通过观察对比舌针联合言语康复训练法与言语康复训练法治疗中风后运动性失语的疗效，探讨舌针联合言语康复训练治疗中风后运动性失语的有效性及优越性，为临床治疗运动性失语提供一个科学的、综合有效的联合方案，同时也能更好的传承名老中医管正斋教授的学术思想。

方法：纳入符合标准的中风后运动性失语患者共计 72 例，随机分为舌针组和对照组，各 36 例。两组患者均给予相同的基础治疗（内科常规治疗和基础针刺治疗）。舌针组：舌针联合言语康复训练；对照组：言语康复训练；共治疗 2 个疗程，分别于治疗前、治疗后观察并比较简化版《汉语失语症检查表(ABC)法》的复述、谈话、命名、理解 4 项语言功能的评分、《波士顿诊断性失语症检查法(BDAE)》言语功能分级和疗效的评价。最后对数据进行统计分析，比较两组之间的临床疗效。

结果：

（1）两组患者在性别、年龄及年龄段分布构成、病程及病程段分布构成等基线资料方面比较的差异均无统计学意义（P均＞0.05），具有可比性。

（2）简化版《汉语失语症检查表(ABC)法》的评分结果：两组患者治疗前 4 项言语功能评分比较均无统计学意义（P均＞0.05），具有可比性；治疗后两组患者的理解评分组间比较无统计学意义，组内比较具有统计学意义；治疗后两组患者复述、谈话、命名的组内及组间评分均有显著性差异，具有统计学意义。

（3）BDAE 言语功能的分级比较结果：两组治疗前差异无统计学意义（P＞0.05），具有可比性；两组治疗后言语功能分级均有提升，组内和组间比较均有统计学意义，舌针组的言语功能优于对照组。

（4）疗效评价：对照组的总有效率为 67.65%，舌针组的总有效率为 88.24%。两组的差异具有统计学意义（P＜0.05），表明舌针组总有效率高于对照组。

结论：

（1）舌针联合言语康复训练与言语康复训练均能提高中风后运动性失语患者的语言功能，均有良好的效果；

中国知网 https://www.cnki.net

（2）舌针联合言语康复训练治疗中风后运动性失语的临床疗效优于言语康复训练，对于提高患者的复述、谈话、命名功能，改善病人失语严重程度的效果更为显著，并且安全、操作简单方便，临床值得推广和应用。

关键词：中风；运动性失语；管氏舌针；言语康复

中国知网 https://www.cnki.net

Clinical study of tongue acupuncture combined with language rehabilitation training in the treatment of motor aphasia after stroke

Abstract

Objective: To observe the curative effect of tongue acupuncture combined with language rehabilitation training and simple language rehabilitation training in the treatment of post-stroke motor aphasia,and to explore the effectiveness and superiority of tongue acupuncture combined with language rehabilitation training in the treatment of post-stroke motor aphasia,and to provide a scientific,comprehensive and effective program for the treatment of motor aphasia,but also to better inherit the academic thought of Professor Guan Zhengzhai,an old Chinese medicine professor.

Methods:In accord with a standard motor aphasia after stroke patients a total of 72 cases, were randomly divided into latch needle group and the control group, all the 36 cases..Both groups were given the same basic treatment(routine medical treatment and basic acupuncture treatment).Tongue acupuncture group:tongue acupuncture combined with language rehabilitation training;control group:language rehabilitation training only;The whole treatment include two courses of treatments and one course of treatment includes 6 times acupuncture every week.To observe and compare the scores of the four language functions of the simplified Aphasia Battery of Chinese(ABC)scale,the classification of speech functions of the Boston Diagnostic Aphasia Examination(BDAE)scale and evaluation of efficacy before and after treatment.Finally,statistical analysis of the data was carried out,and compare clinical efficacy between two groups.

Results:

(1)Two groups of patients in the gender, age, and age distribution structure, course and course of the period of baseline data, such as the distribution form comparative differences were no statistical significance ($P > 0.05$), which was comparable.

(2)The score results of retelling,talking, naming, understanding of simplified ABC scale:four words function score before treatment in both groups is no statistical significance ($P > 0.05$).After treatment, there was no significant difference of understanding

中国知网 https://www.cnki.net

score between the two groups,and the intra-group comparison was statistically significant;There were significant differences in the scores of retelling, talking, naming within group and between groups after treatment, which were statistically significant.

(3)The score results of classification of language function about BDAE scale:before the treatment, there was no significant difference (P>0.05) between the two groups;The speech function grade was improved after treatment in both groups;There were statistically significant intra-group and inter-group comparisons of speech function classification between the two groups after treatment,and the speech function of tongue acupuncture group was better than that of control group.

(4)evaluation of therapeutic efficiency:The total effective rate of the control group was 67.65% and that of the tongue acupuncture group was 88.24%.The results showed that the effective rate of tongue acupuncture group was higher than that of control group.

Conclusions:

(1)Tongue acupuncture combined with speech rehabilitation training and speech rehabilitation training alone can improve the speech function of patients with motor aphasia after stroke, and both have good effects.

(2) The clinical effect of tongue acupuncture combined with speech rehabilitation training in the treatment of motor aphasia after stroke is better than that of speech rehabilitation training alone,and the effect of improving the function of retelling,talking and naming is more significant.Meanwhile,it is safe and reliable, easy to operate,fast recovery of language function, and worthy of popularization and application in clinic.

Keywords:stroke;motor aphasia;Guan's tongue acupuncture;language rehabilitation

中国知网 https://www.cnki.net

中英文缩略词对照表

英文缩略词	英文全拼	中文翻译
BA	Broca’s aphasia	运动性失语
ABC	Aphasia Battery in Chinese	汉语失语症成套测验
BDAE	Boston Diagnostic Aphasia Examination	失语症严重程度分级标准

中国知网 https://www.cnki.net

引　言

中风，即脑卒中，是我国发病率较高的病种之一，其发生的主要原因在于人体脑组织的血液循环功能发生了病变，导致脑部出现缺血、缺氧，使局部出现缺血性坏死或软化，伤及相对应的神经功能区域，从而出现一系列的功能障碍[1]。每年确诊为脑卒中的中国人群大概有200万人，而造成中国人群死亡的主要原因就是脑卒中，其中70%～80%的脑卒中患者会出现各种功能障碍，严重影响他们的生活质量，对人类的生命健康安全造成了巨大的威胁和危害[3]。最近几年在无数医务工作者的努力和创新下，我国医疗技术水平有了很大的进步，中风致死的人数较之前显著减少，但中风后的致残率却相对增高，中风患者中大约有57%～69%伴有语言障碍[4]。中风后失语症中常见的类型是运动性失语，又称Broca’s失语（Broca’s aphasia，BA），这种失语类型患者的理解和听能力障碍不明显，但口语方面表达能力障碍突出为主要临床特点[5]。运动性失语患者在日常生活中由于言语功能障碍，很难和别人进行有效的交流沟通，严重影响患者的日常生活，让患者感觉自己难以融入社会，不仅使患者的幸福感下降，还会给患者带来极大的压力，时间一长，患者有极大的可能出现心理问题，比如焦虑、抑郁、失眠等，给其家庭和社会造成严重的负担和压力。有调查显示，中风后的1、2、3个月时其抑郁发病率分别为23.6%、32.9%、42.2%[6]。因此，我们医务工作者和社会必须重视对于中风后运动性失语患者言语功能恢复和心理健康的治疗。

中国古代医者并未将“中风后失语”命为病名，而是当做中风患者的兼症，主要表现为发音不出或声音嘶哑、言语蹇涩或舌强不能言等，相当于中医概念中“喑痱”、“瘖俳”、“风喑”、“风懿”、“难以言”等。失语的原发病是中风，所以中风后失语的病因也不外乎虚、风、火、痰、气逆、血瘀六端，邪阻舌窍、心窍、脑窍以及影响经脉、脏腑[7]。

目前临床上西医治疗除了言语康复训练、药物治疗以外，还有近年来较为热门的低频电刺激疗法、经颅直流电刺激等治疗。但这些方法的治疗效果并不是很理想，疗程长、远期效果不佳，最主要还会产生某些副作用，而针灸凭借着可以调气血、平衡阴阳、舒筋络，通舌窍，操作方便，费用低且长期疗效明显等特点，受到了越来越多的医务工作者们的青睐。

中国知网 https://www.cnki.net

有指南中提出：在中风病人患病早期连续进行强度较大的言语训练治疗非常有利于患者症状恢复[3]。实践证明，合适的言语训练能够使患者的功能得到较快的恢复，提升患者的幸福指数，缩短患者康复疗程，为患者家庭节省部分费用，充分的利用社会资源[8]。但单纯的言语康复训练疗程长，治疗成本较高，患者配合度差，因此我们需要研究更好的联合疗法。

管氏舌针是由管正斋老中医于 1936 年创立的一种特殊针法。前期临床观察表明，管氏舌针治疗中风后失语有着独特的疗效，但经查阅文献发现，与舌针相关的文献较少，此外，舌针的作用机制也尚不明确。李世龙等人[9]认为舌针可能是通过针刺舌体上的穴位，刺激到了舌部的多处神经等，向上传到延髓核团，高级神经中枢接受到信号，可能通过皮层－丘脑－皮层的调节，使各传导系统相互协调，增加神经兴奋性及数量，使尽快恢复坏死的病灶，从而达到治疗言语功能的作用。

本研究是在我的导师指导下，采用管氏舌针联合言语康复训练治疗失语患者，旨在通过观察该法对失语患者的治疗效果，评价管氏舌针联合言语康复训练的有效性、优越性及安全性，丰富治疗方法，同时也能更好的传承名老中医管正斋教授的学术思想。

中国知网 https://www.cnki.net

正　文

资料与方法

1 研究资料

1.1 病例来源

本课题所收集的病例均来自昆明市中医医院的针灸科及康复科自2019年12月至2020年12月符合标准的住院患者72例。

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准

1.2.1.1 西医诊断标准

参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[1]中的缺血性脑卒中的诊断标准拟定：

①急性起病；

②局灶神经功能缺损(一侧面部或肢体无力或麻木，语言功能障碍等），少数为全面神经功能缺损；

③症状或体征持续时间不限(当影像学显示有责任缺血性病灶时），或持续24小时以上(当缺乏影像学责任病灶时）；

④排除非血管性病因；

⑤经影像学检查排除脑出血。

1.2.1.2 运动性失语诊断标准

运动性失语的诊断，参照简化的《汉语失语成套测验》（附录二）[10, 11]。记录患者4项的得分，低于总分者，则加入课题组。

1.2.1.3 中医诊断标准

（1）中医诊断标准

参照中华人民共和国中医药行业标准《中医内科病证诊断疗效标准》[12]中的中风病的诊断为标准。

①以半身不遂、口舌歪斜、舌强言謇，偏身麻木，甚则神志恍惚、迷蒙、神昏、

中国知网 https://www.cnki.net

昏愦为主症。

②发病急骤，有渐进发展过程。病前多有头晕头疼，肢体麻木等先兆。

③常有年老体衰，劳倦内伤，嗜好烟酒等因素。每因恼怒、劳累、酗酒、感寒等诱发。

④做血压、神经系统、脑脊液、血常规等检查，有条件做 CT、MRI，可有异常表现。

（2）病类诊断

①中脏腑：中风病有意识障碍者。

②中经络：中风病无意识障碍者。

1.3 纳入标准

标准	内容
	（1）符合西医缺血性脑卒中、运动性失语及中医中风病（中经络）的诊断标准 （2）患者意识状态清醒，病情平稳，能够积极配合治疗，病程在半个月至 6 个月，并且中风次数＜2 次 （3）舌部及发音器官等完好，无外伤史 （4）母语为汉语，能认识常用的汉字 （5）经影像学检查证实为脑梗死 （6）年龄选择在 30～80 岁之间的患者，男女不限 （7）患者及家属知情并愿意参加该研究，与课题组签署知情同意书

1.4 排除标准

标准	内容（符合任意一项者即可排除）
	（1）不符合诊断标准和纳入标准的患者； （2）患有有严重视、听力及意识障碍者； （3）无法主动配合治疗者； （4）有其他脏器的严重疾病或焦虑症、精神不正常的患者； （5）处于准备孕或怀孕或哺乳期的女性患者； （6）目前正参加其他临床研究的患者； （7）非外伤情况下各种原因引起的出血或凝血功能不佳的患者；

中国知网 https://www.cnki.net

1.5 剔除标准与脱落标准

标准	内容（凡符合任意一项者，即可剔除或脱落）
	（1）参加研究的病人不遵守分组规则； （2）患者不配合治疗，影响疗效的比较； （3）患者依从性不好，无法坚持完成整个临床研究； （4）恐惧针灸治疗者； （5）治疗过程中中出现严重不良或严重并发症的患者；

2 研究方法

2.1 病例的随机分组

通过SPSS26.0得出随机数字表，制成随机数字卡共72张，按照合格患者的就诊顺序，1:1随机分为两组即舌针组36例，对照组36例。

2.2 治疗方法

2.2.1 基础治疗

所有患者在参与研究的2周期间均需根据自身情况给予相对应的综合治疗，主要包括：

（1）内科常规治疗：针对患者的基础疾病进行用药，做好中风病的二级预防工作。

（2）基础针刺治疗：采用高树中、杨骏主编的“第九版全国高等中医药院校规划教材”《针灸治疗学》[13]中“中风病”的治疗方案。

①主穴：水沟、内关、极泉、尺泽、三阴交、廉泉、通里、哑门

配穴：根据患者自身情况，随症选穴。

②针具选用

针具选用规格为：0.25mm×25mm和0.25mm×40mm的一次性无菌针灸针（苏州市华伦医疗用品有限公司生产）。

③操作方法

参考卫生部“十三五”国家级规划教材《针灸治疗学》[13]中针刺深度及针刺方向操作。

患者选择合适的体位，充分暴露针刺部位，常规针刺消毒。先取坐位，哑门穴快

中国知网 https://www.cnki.net

针而不留针，以有针感为度；再取仰卧位，具体如下：水沟用雀啄法，以眼球湿润为度；内关用捻转泻法；极泉在原来的穴位往下 1 寸的心经上取穴，需要避开腋毛，以直刺进针的方法，使出现上肢有麻胀感和抽动；廉泉，将针尖超向舌根斜刺；尺泽、通里均直刺，提插泻法，三阴交用提插补法。

2.2.2 舌针组

2.2.2.1 针刺治疗：

（1）选穴

参照《管遵惠学术经验撷菁》[14]。

穴位处方：心穴(位于舌尖后 5 分)、双侧肝穴(位于舌面后 1/3 处，边缘向内 5 分处)、双侧脾穴(位于舌面中央处旁左右分开 4 分处)、双侧肾穴(位于舌面中央后 3 分，外开 4 分处，)、聚泉(位于舌面中央处)、金津、玉液、中矩(舌根底与牙齿龈交界处)、舌柱(舌上举，在舌下之筋如柱上)。详见图 1-2。

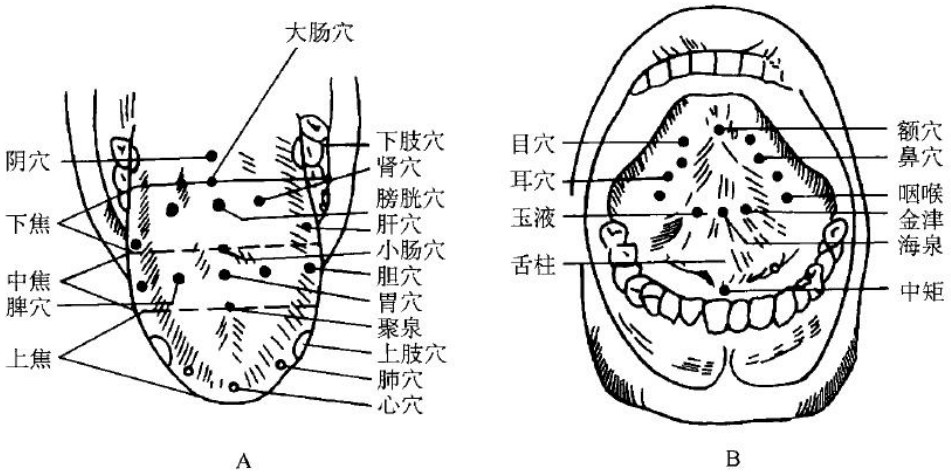

图 1-2 管氏舌针穴位分布

A. 舌面；B. 舌底

（2）针具选用

针具选用规格为：0.25mm×50mm 或 0.25mm×40mm 的一次性无菌针灸针（苏州市华伦医疗用品有限公司生产）。

（3）操作方法

参照《管遵惠学术经验撷菁》[14]。

患者取舒适的体位，嘱患者充分暴露舌体；针刺前嘱患者使用复方口灵茶多酚含

中国知网 https://www.cnki.net

漱液漱口，请患者自然把舌伸出口外。根据患者口腔情况选用长度合适的针灸针，每次选3个穴，交替进行：位于舌面上的穴位，进针后用拇指前后均匀捻转9次，进针深度一般约为1～3 mm，勿刺太深；位于舌底的4个穴位，嘱患者完成把舌向上卷起，充分暴露舌底的位置，如果患者无法将舌卷起，医师可以借助自己的左手，将舌体用无菌纱块固定，向上提起患者的舌，充分暴露舌底的穴位，再进行针刺，均不留针。

2.2.2.2 言语康复训练方法[15]：

采用Schuell刺激法训练患者的言语能力，每位患者将由康复医师对患者进行康复训练。每次治疗30分钟，每日1次，每周训练6天，休息1天，1周为1个疗程，共治疗2个疗程。

2.2.3 对照组

只采用言语康复训练方法：治疗方法、操作同舌针组的言语康复训练。

2.2.4 疗程

两组均每日治疗1次,治疗6天休息1天，7天为1个疗程,治疗2个疗程。

2.3 观察指标

2.3.1 一般性指标

（1）人口学资料

包括年龄、性别、病程等。

（2）观察点

分别在治疗前、结束后。

（3）安全性指标

是否发生不良事件（需随时记录）。

2.3.2 观察指标

两组均在治疗前、后就以下指标进行观察:

（1）采用简化版ABC量表（附件一）评分，记录复述、谈话、命名、理解4项语言功能的得分。

（2）通过BDAE量表（见附件二）进行言语功能分级，获得两种方案治疗中风后失语患者言语功能恢复的结果。

2.3.3 综合疗效评定

疗效评价：记录治疗前、治疗后的4项语言功能的得分。具体如下:

中国知网 https://www.cnki.net

改善率=(治疗后得分-治疗前得分)/(正常得分-治疗前得分)×100%。

显效:改善率≥50%

有效:30%≤改善率<50%

进步:10%≤改善率<30%

无效:改善率<10%

2.4 统计分析

所有数据采用 SPSS26.0 统计软件进行分析，计量资料采用均数±标准差表示。计量资料在符合正态分布的条件下，组间比较采用独立样本 t 检验，组内比较选用配对 t 检验，计数资料采用 χ^2 检验，计量资料不符合正态分布的采用秩和检验，所有检验的水准取 0.05。以 $P<0.05$ 作为具有统计学意义，以 $P<0.001$ 作为具有高度统计学意义。

2.5 技术关键

（1）“舌针”操作和言语康复训练的培训：研究开始前对操作的固定针灸医师和康复师进行培训。

（2）严格遵循本课题中的各项标准完成选择病例的工作。

（3）患者参与课题研究的过程中需要做好患者的思想工作，交代注意事项等，确保患者配合医生并坚持完成所有治疗和各项指标的评分。

（4）取穴的准确性：严格参照《管遵惠学术经验撷菁》[16]及普通高等教育“十二五”国家级规划教材《经络腧穴学》[17]。

（5）准确记录临床数据，采用科学的统计学方法对数据资料进行统计分析。

中国知网 https://www.cnki.net

研究结果

1 病例完成情况分析

共纳入 72 例符合标准的患者，随机分为舌针组和对照组各 36 例。舌针组中完成研究者共计 34 例，因惧怕针刺脱落 2 例，对照组中完成研究者共计 34 例，因惧怕针刺脱落 1 例，患者因个人原因未坚持完成治疗脱落 1 例，其余依从性较好，两组共计 68 例完成本研究。

2 一般资料分析

本课题中实际纳入 68 例患者，其中舌针组：女性 16 例，男性 18 例；年龄 40~77 岁之间，病程为 20~120 天；对照组：女性 14 例，男性 20 例；年龄在 40~77 岁之间；病程在 28~108 天之间。

2.1 两组患者的基线资料比较

表 1 中风后运动性失语患者的基线资料比较

基线资料	对照组（n=34）	舌针组（n=34）	统计值	P值
性别（例）			χ^2=0.239	0.625
男	20	18		
女	14	16		
年龄（$\bar{x}\pm s$，岁）	57.21±9.08	57.85±8.85	t=0.297	0.767
病程（$\bar{x}\pm s$，天）	55.24±18.85	59.38±23.42	t=0.804	0.424

中国知网 https://www.cnki.net

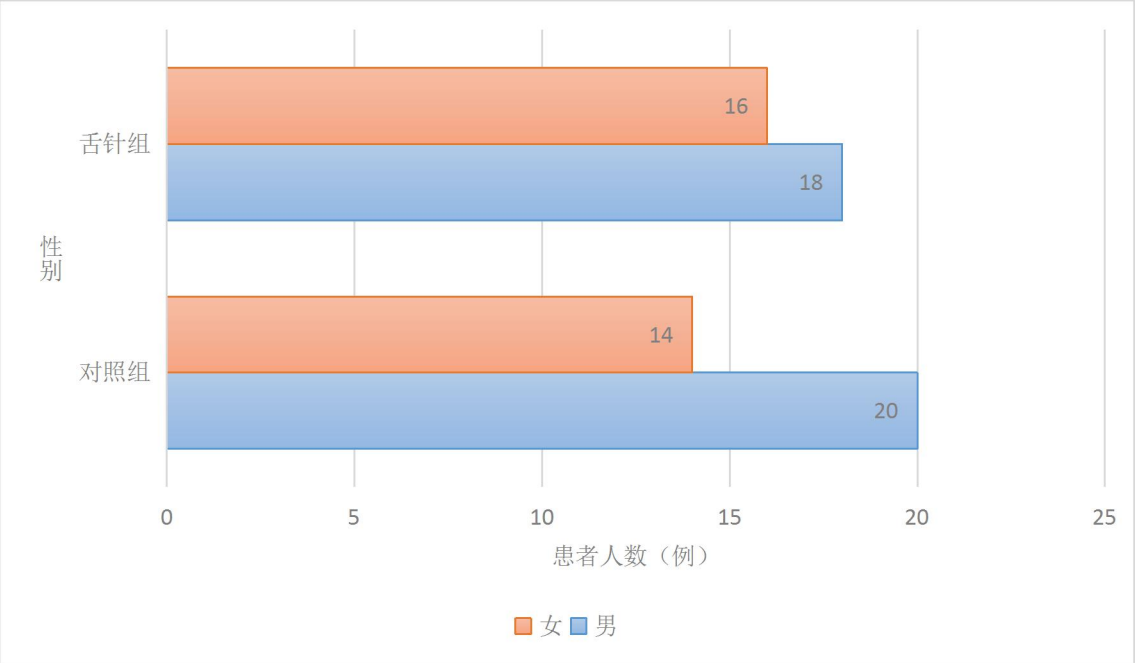

图 3 两组患者性别比较

表 2 两组患者年龄段分布比较

年龄（岁）	对照组（例）	舌针组（例）	卡方检验	
			统计值	*P* 值
≤40	1	1	X^2=0.564	0.905
41~50	7	6		
51~59	14	12		
≥60	12	15		

中国知网 https://www.cnki.net

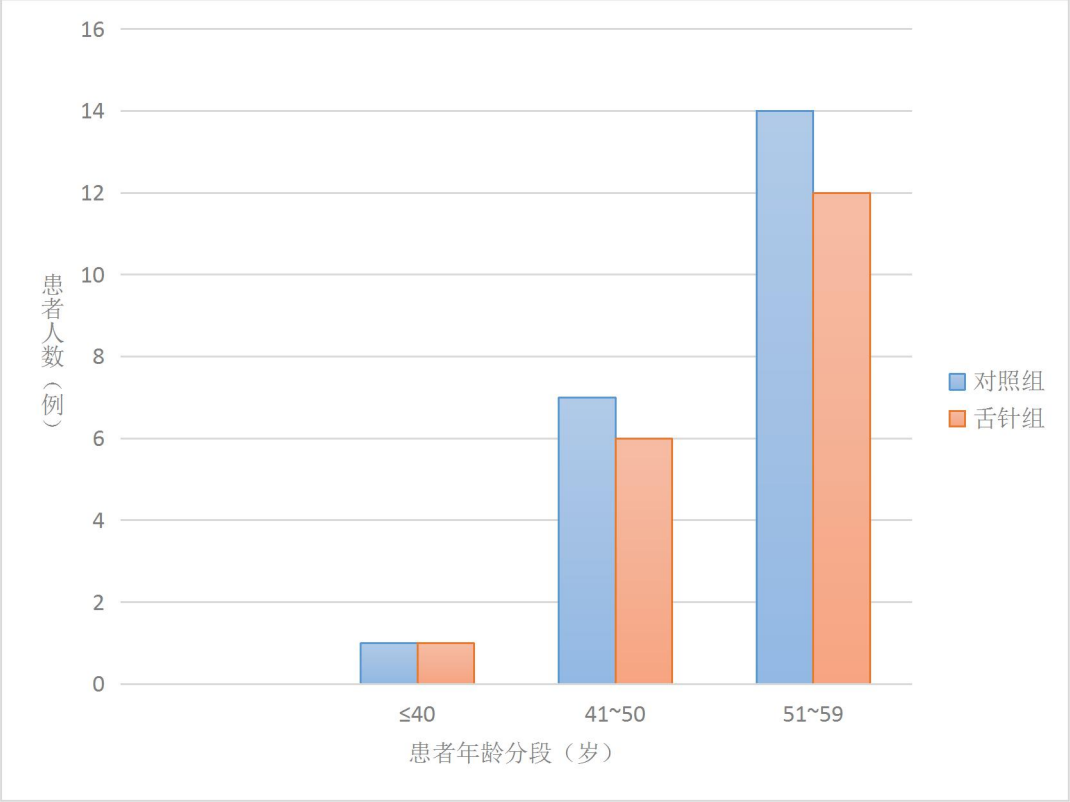

图 4 两组患者年龄段比较

表 3 两组患者病程段分布比较

病程（天）	对照组（例）	舌针组（例）	卡方检验	
			统计值	*P* 值
≤40	9	6	X^2=1.119	0.772
41~50	6	8		
51~59	6	5		
≥60	13	15		

中国知网 https://www.cnki.net

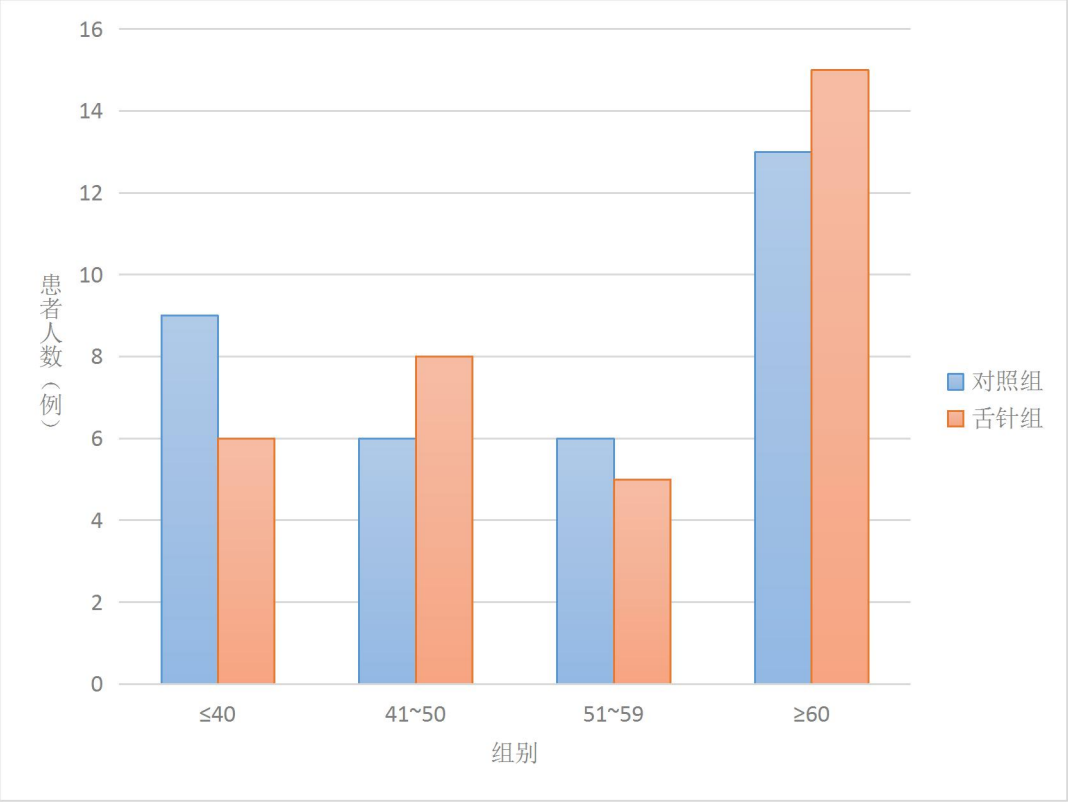

图 5 两组患者病程段比较

如表 1、2、3 及图 3、4、5 所示，两组患者在性别、年龄及年龄段分布构成、病程及病程段分布构成基线资料方面比较差异均无统计学意义（P 均大于 0.05），具有可比性。

3 观察指标分析

3.1 两组患者治疗前后 4 项语言功能的评分比较

3.1.1 两组患者治疗前后的复述评分比较

治疗前后两组患者的复述评分不满足正态分布，采用非参数检验。治疗前两组组间比较，P=0.955（＞0.05），说明差异无统计学意义，具有可比性。对照组及舌针组治疗前后比较，P 均＜0.001，说明治疗前后对照组及舌针组的差异均有统计学意义；治疗后两组组间比较，P＜0.001，说明治疗后两组的差异有高度统计学意义；两组治疗前后复述评分的差值比较，P＜0.001，说明两组的差值的差异有高度统计学意义。以上结果表明：经过两种方法治疗后，患者的复述功能的评分均有提高，并且舌针组效果优于对照组。见表 4、图 6。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4 两组患者治疗前后及差值的复述评分比较[M（P_{25}, P_{75}）]

处理分组	治疗前（分）	治疗后（分）	差值	秩和检验	
				Z 值	*P* 值
对照组	4.0(3.0,5.0)	6.0(5.0,6.0)	2.0（2.0，2.0）	-5.266	<0.001
舌针组	4.0(3.0,5.0)	7.0(6.0,8.0)	3.0（3.0,3.0）	-5.388	<0.001
Z 值	-0.057	-4.300	-6.405		
P 值	0.955	<0.001	<0.001		

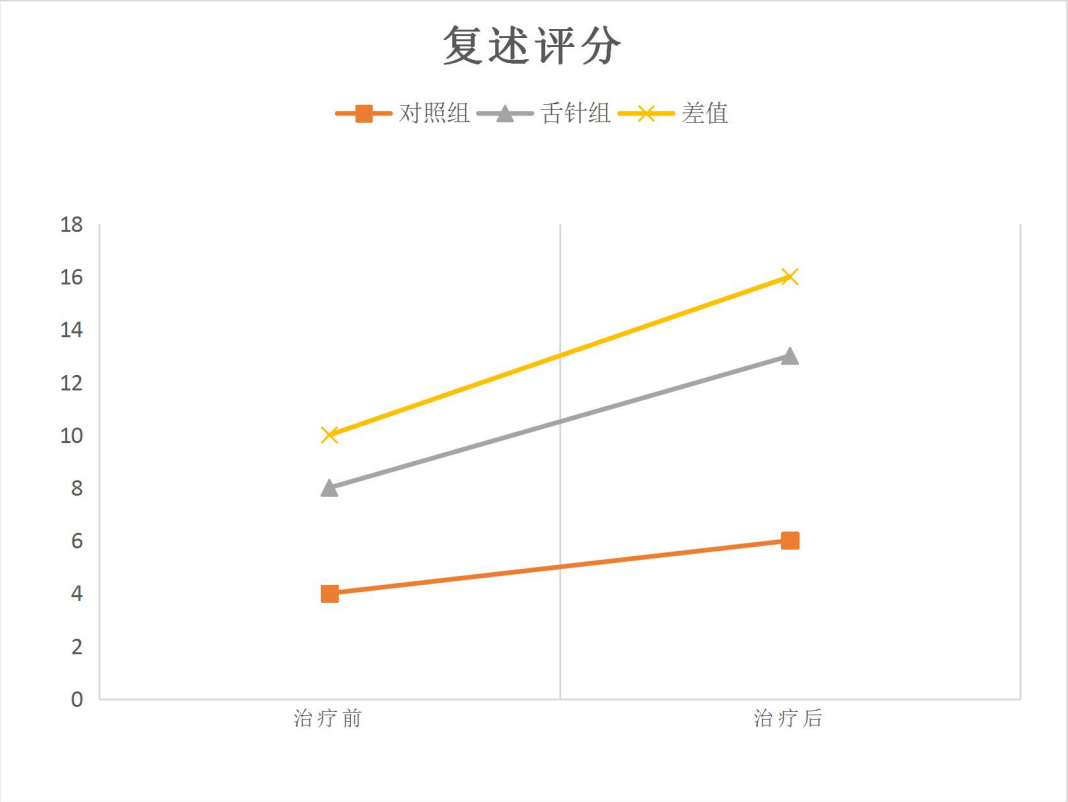

图 6 两组患者复述评分比较

3.1.2 两组患者治疗前后的谈话评分比较

治疗前后两组患者的谈话评分呈正态分布。治疗前两组组间比较，P=0.955，两组差异无统计学意义，具有可比性；对照组及舌针组治疗前后分别比较，P 均＜0.001，说明对照组及舌针组治疗前后的差异均有统计学意义；治疗后两组组间比较，P=0.003（＜0.05），说明治疗后两组的差异有统计学意义。两组治疗前后差值比较，P＜0.001，两组差异有统计学意义。以上结果表明：经过两种方法治疗后，患者的谈

中国知网 https://www.cnki.net

话功能的评分均有提高，并且舌针组的效果优于对照组。见表 5、图 7。

表 5 两组患者治疗前后及差值的谈话评分比较（ $\bar{x}\pm s$）

处理分组	治疗前（分）	治疗后（分）	差值	秩和检验	
				t 值	*P* 值
对照组	3.62±1.37	6.63±1.35	3.01±0.02	7.105	<0.001
舌针组	3.56±1.42	7.62±1.37	4.06±0.05	9.904	<0.001
t 值	0.174	3.060	6.250		
P 值	0.860	0.003	<0.001		

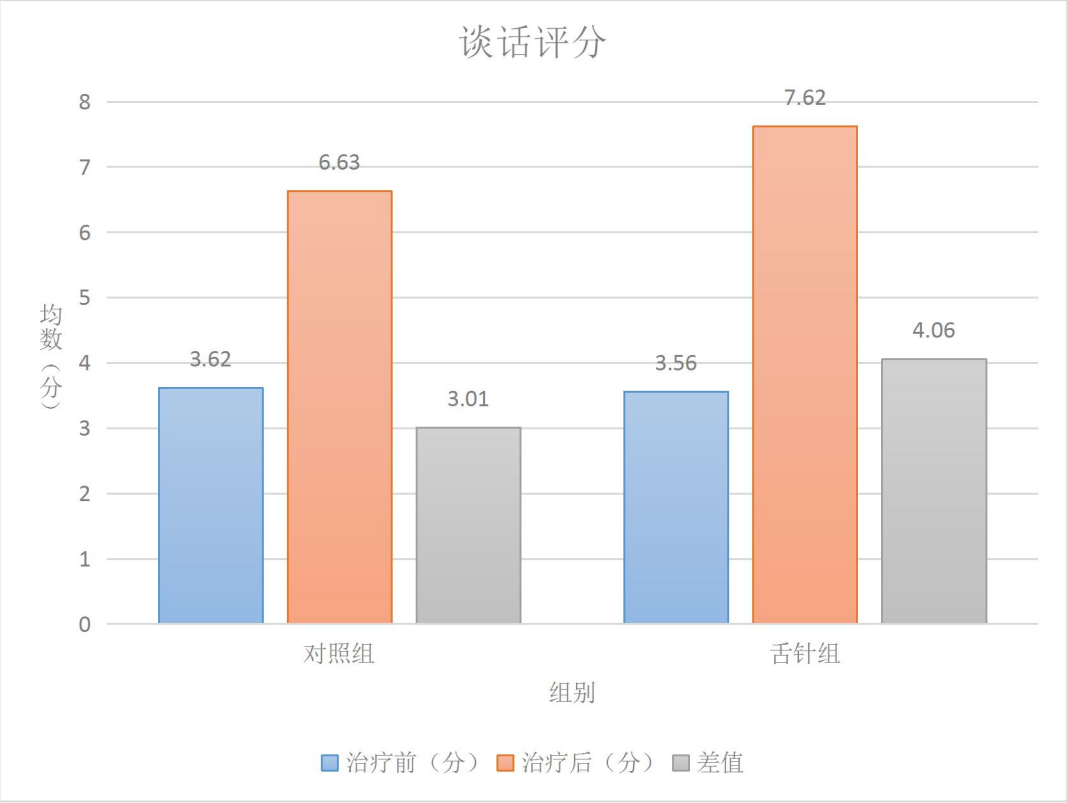

图 7 两组患者谈话评分比较

3.1.3 两组患者治疗前后的理解评分比较

治疗前后两组患者的理解评分呈正态分布。治疗前两组组间比较，*P*=0.898，两组差异无统计学意义，具有可比性；对照组及舌针组治疗前后分别比较，*P* 均<0.001，说明对照组及舌针组治疗前后的差异均有统计学意义；治疗后两组组间比较，*P*=0.598（>0.05），说明治疗后两组的差异无统计学意义；两组治疗前后差值比较，*P*=0.412，两组差异无统计学意义。以上结果表明：经过两种方法治疗后，患者的理解功能的评分均有提高，但两组对于提高理解评分的疗效无差异。见表 6、图 8。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6 两组患者治疗前后的理解评分比较（ $\bar{x}\pm s$）

处理分组	治疗前（分）	治疗后（分）	差值	秩和检验	
				t 值	*P* 值
对照组	4.82±1.68	9.31±2.24	4.49±0.56	1.266	<0.001
舌针组	4.77±1.53	9.59±2.11	4.82±0.58	1.388	<0.001
t 值	0.128	0.531	2.387		
P 值	0.898	0.598	0.412		

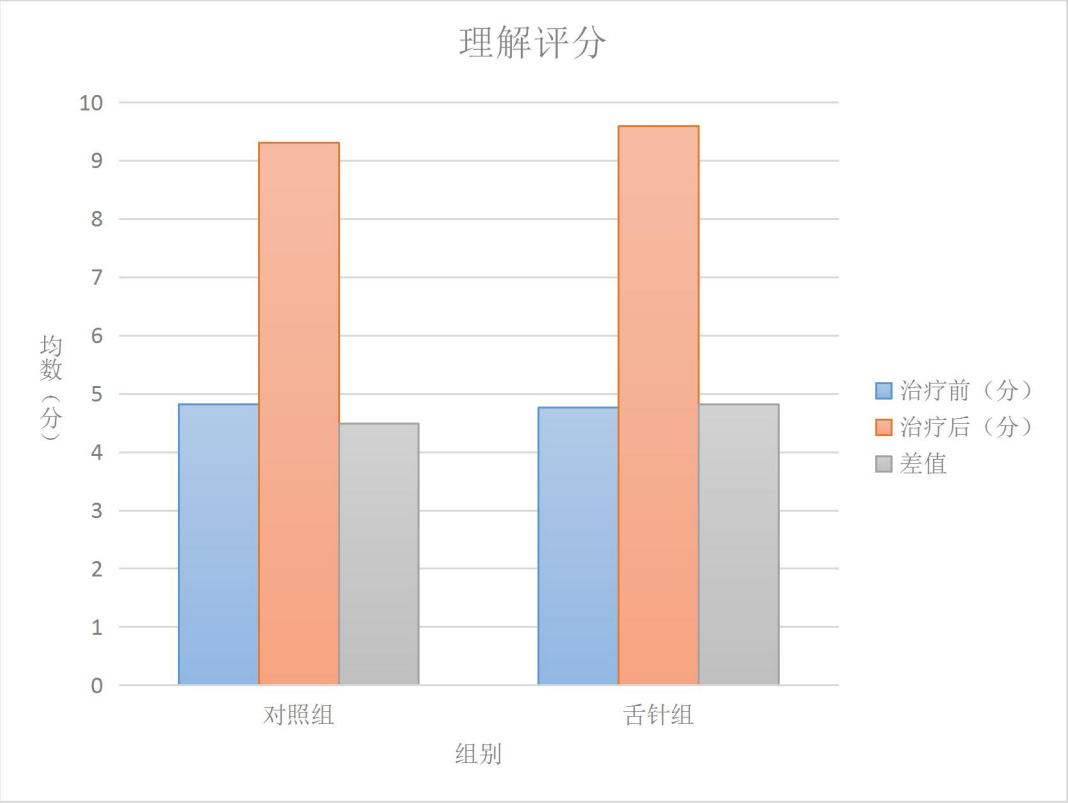

图 8 两组患者理解评分比较

3.1.4 两组患者治疗前后的命名评分比较

治疗前后两组患者的命名评分呈正态分布。治疗前两组组间比较，*P*=0.801，两组差异无统计学意义，具有可比性；对照组及舌针组治疗前后分别比较，*P* 均<0.05，说明对照组及舌针组治疗前后的差异均有统计学意义；治疗后两组组间比较，*P*=0.038（<0.05），说明治疗后两组的差异有统计学意义；两组治疗前后差值比较，*P*<0.001，提示差值的差异有统计学意义。以上结果表明：经过两种方法治疗后，患者的命名功能的评分均有提高，并且舌针组的效果优于对照组。见表 7、图 9。

中国知网 https://www.cnki.net

表 7 两组患者治疗前后的命名评分比较（ $\bar{x}\pm s$）

处理分组	治疗前（分）	治疗后（分）	差值	秩和检验	
				t 值	*P* 值
对照组	6.29±2.57	9.86±2.78	3.57±0.21	2.469	0.014
舌针组	6.44±2.31	11.60±3.91	5.16±1.60	3.988	0.005
t 值	0.253	2.115	5.745		
P 值	0.801	0.038	<0.001		

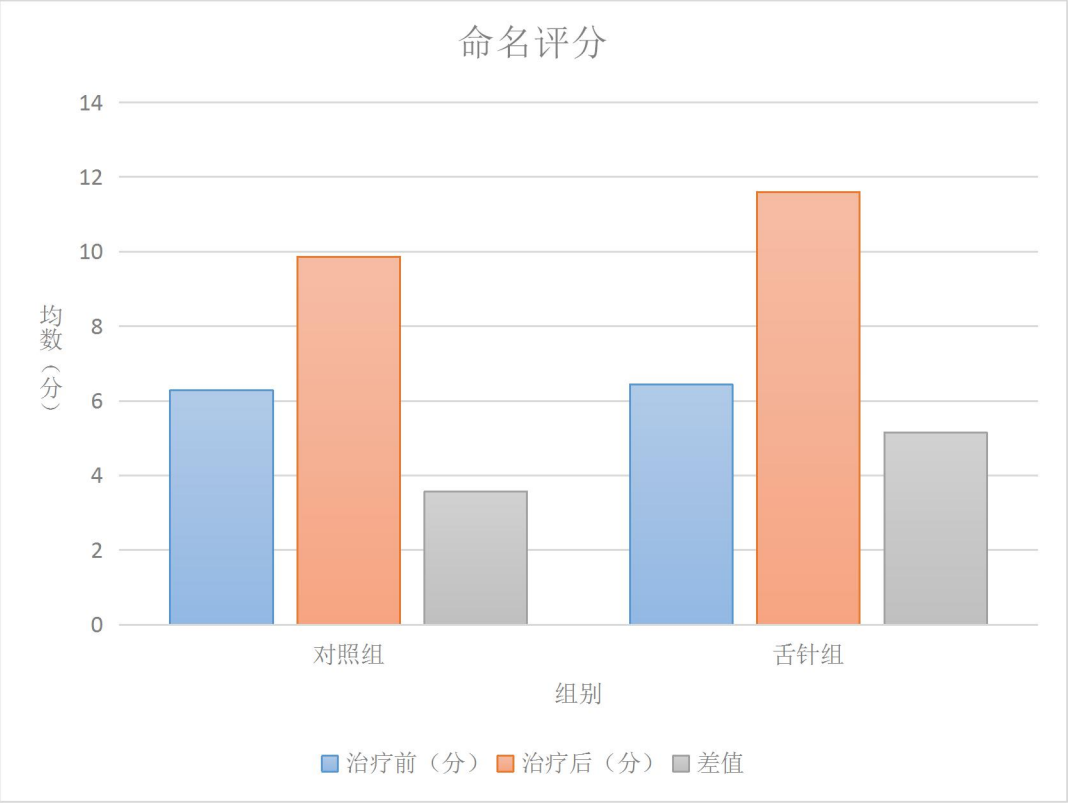

图 9 两组患者命名评分比较

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 两组患者治疗前后 BDAE 的言语功能分级比较

表 8 两组患者治疗前 BDAE 分级比较

组别	等级（例）						*Z*值	*P*值
	0 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级		
对照组	2	11	10	9	2	0	-0.435	0.663
舌针组	1	9	14	7	3	0		

注：经秩和检验，Z 值=-0.435，*P*值=0.663＞0.05，差异无统计学意义，具有可比性。

表 9 舌针组患者治疗前后 BDAE 分级比较

治疗前	治疗后（例）						*Z*值	*P*值
	0 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级		
0 级	0	1	0	0	0	0	-5.229	<0.001
1 级	0	0	3	3	3	0		
2 级	0	0	0	7	5	2		
3 级	0	0	0	0	6	1		
4 级	0	0	0	0	0	3		
5 级	0	0	0	0	0	0		

注：经秩和检验，*Z*值=-5.229，*P*值<0.001，差异具有高度统计学意义。

表 10 对照组患者治疗前后 BDAE 分级比较

治疗前	治疗后（例）						*Z*值	*P*值
	0 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级		
0 级	0	2	0	0	0	0	-5.387	<0.001
1 级	0	1	9	1	0	0		
2 级	0	0	0	9	1	0		
3 级	0	0	0	0	7	2		
4 级	0	0	0	0	1	1		
5 级	0	0	0	0	0	0		

注：经秩和检验，*Z*值=-5.387，*P*值<0.001，差异具有高度统计学意义。

中国知网 https://www.cnki.net

表 11 两组患者治疗后 BDAE 分级比较

组别	等级（例）						*Z*值	*P*值
	0 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级		
对照组	0	3	9	10	9	3	-2.317	0.021
舌针组	0	1	3	10	14	6		

注：经秩和检验，Z 值=-2.317，*P*值=0.021＜0.05，差异有统计学意义。

结合表 8、9、10、11，分析比较，可得出结论：两组均能提高中风后运动性失语患者的言语功能；舌针组的效果优于对照组。

4 疗效评价

按照疗效评价标准，对照组总有效率为 67.65%，舌针组的总有效率为 88.24%。经卡方检验后，*P* 值=0.026（＜0.05），说明舌针组总有效率高于对照组，具有统计学意义。见表 12、图 10。

表 12 两组患者疗效评价

组别	显效（例）	有效（例）	进步（例）	无效（例）	总有效率
对照组	3	7	13	11	67.65%
舌针组	9	13	8	4	88.24%
X^2	9.257				
*P*值	0.026				

中国知网 https://www.cnki.net

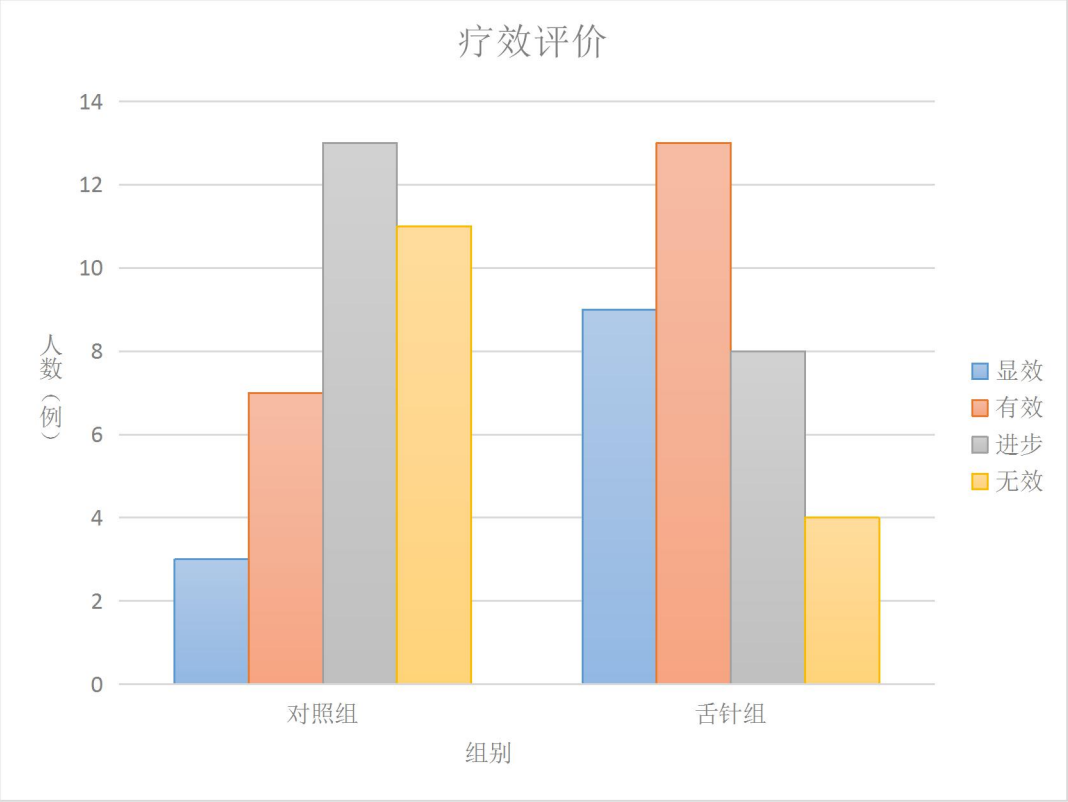

图 10 两组患者疗效评价

5 安全性分析

本次临床课题研究中，共 68 例患者完成治疗，研究开始前对操作的固定针灸医师进行“舌针”培训，治疗过程中与患者沟通良好，患者均未发生生命体征异常、晕针、断针、弯针、滞针、瘀血等情况，不良反应判定为 1 级。提示舌针对于治疗中风后运动性失语患者的安全性良好。

中国知网 https://www.cnki.net

讨 论

1 立题依据

中风，也就是我们常说的脑卒中。在脑血管疾病里最易使患者发生死亡或者残疾的疾病类型当属脑卒中，并且我国在人口老龄化现象越来越严重的背景下，中风人数逐年增多，发病率也越来越高，这不仅影响患者的日常社交能力，还给患者心理和生活带来极大的痛苦和不便，同时也加重了患者家庭及社会的负担。近年来由于医疗技术一直在不断地提高，明显降低了中风致死率，但发生后遗症的几率却相对增高，据统计，中风后失语症的发病率高达38%[18]。因此，医生及社会应高度关注中风后仍遗有失语的患者。本课题以中风后运动性失语为切入点，比较失语患者运用舌针联合言语康复训练与单纯言语康复训练治疗失语患者之间的疗效差别为研究目的，主要是为医者在临床应用中提供一种更有效、更方便、更科学的综合治疗方法，其最主要的目的是能够达到更显著的疗效，让患者的生活质量有一个质的提升，从而帮助患者们融入社会，回归正常生活。选择本课题的关键是进一步探索管氏舌针治疗该病的优越性以，为提高中风后失语患者的针灸疗效提供一个科学的临床依据。

2 祖国医学对中风后运动性失语的认识

2.1 祖国医学对于病名的认识

祖国医学里并没有“失语”这个病名，最早出现在《黄帝内经》中：“瘖痱”。高世栻在《素问直解》中说到:“瘖痱者，口无言而四肢不收[19]。”《医宗金鉴心法集要》:“四肢不收无痛痱，偏枯身偏不用疼……甚不能言为瘖痱，夺厥入藏病多凶[20]。”这是古代医家最早对失语的认识。大部分医家是把失语当做中风的并发症，随着对中风病的深入认识，越来越多的古代医家对失语的认识也越来越全面，书中记载也越来越多，比如“风懿”“风癔”“风喑”“口噤不能言”“不能言”“中风不语”等都是古代医家对失语病名的常见描述。通过分析古代文献中对失语的认识，得出结论：风喑、舌难以言、舌喑不能言、难言、脾经不语等这些描述不属于理解障碍的失语，而风癔、风懿则相反。在《宋太医局诸科程文格注释》里有说到：“今则奄忽而不知人，喉中噫然而有声，舌本强硬而不语者，则知病变为风癔之候也[21]”。古代医家对失语的记载主要是以记录中风偏瘫为主，失语往往被当做中风的并发症，但对其的认识和治疗上，已具雏形。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 祖国医学对病因、病机的探讨

不同医家对于失语的病因、病机均持有自己的看法。张仲景认为："邪人于脏，舌即难言"，早期一些医家认为外邪侵入导致失语，和中风的病机一样。随着对中风病认识的发展，许多医家逐渐从五脏与经络论治，《证治汇补》中曰："故心脾受风，则舌强难言。肾虚脉萎，则口喑不语[22]"，故失语与心、脾、肾相关；孙思邈认为："风寒之邪，客于肺中，滞而不发，故喑"，肺气受阻，也可致不能言。明代医家戴原礼认为：肝受风可致舌强，语涩，失语和肝密切相关。清代.张志聪在《黄帝内经灵枢集注》中指出："审其有音而言语不清，但责之心肝；能语而无声者，当责之脾肺；不能言语亦无声音者，此肾气之逆也。夫忧则伤肺，肺伤则无声矣；恚怒伤肝，肝伤则语言不清矣"[23]，言语的正常离不开心、肝、脾、肺、肾五脏。蔡圣朝教授认为失语和风、痰、瘀三者有关，邪犯心、脾、肾，经络不通、气滞血瘀而致发病[24]。谭子虎教授认为：出现舌强、语言蹇涩离不开与心的联系，主要是因为心神失养，心脑相通，脑主管语言等功能，心和脑之间的关系也非常密切[25]。王新志[26]通过对古代医家对于失语认识的有关条文归纳总结后，认为痰、瘀、风、火四种病邪伤及心经、脾经、肝经、肾经,风火痰瘀,邪蒙心脑神,阻闭舌窍而致失语,病变涉及心、肾、肝、脾等脏腑,病位主要在于心、舌、脑。

3 现代医学对中风后运动性失语的认识

3.1 中风后运动性失语的病因及恢复机理

运动性失语是以口语表达障碍最突出，目前对于导致失语发生的原因尚未有统一定论。一些学者认为左侧底节区的语言中枢受损导致运动性失语[27]。大部分认为主要原因是多个区域的皮质病变所致，这些区域主要分布在优势半球位于额叶下后部和颞上回、额叶内侧面运动辅区这些范围，此外也还有可能是因为皮层下基底神经节病变[28]。

目前认为，中风后运动性失语的恢复机制可能有以下几种：

（1）神经功能网络重建和代偿学说，即优势半球语言功能丧失后，会引起同侧病灶区域周围脑网络功能重组和非优势半球镜像区域语言能力代偿[29]。

（2）侧支循环的建立，研究表明：初期临床治疗可以使脑部侧支循环及时建立，深层修补病变组织附近组织[30]。侧支循环的建立补充了主干血循环的不足，加快损毁语言功能区的血运，调节病变脑组织的低代谢状态和语言中枢脑功能[31]。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）病灶受损周围脑组织水肿的减轻，恢复脑血管的再灌注，保护脑神经[32]。

3.2 现代医学治疗现状

目前，临床治疗多样化，言语康复训练仍是治疗运动性失语的主流；还有非侵入性的脑刺激治疗，比如：低频电刺激疗法、重复经颅磁刺激和经颅直流电刺激等，此外药物治疗也是近年的热门，主要采用乙酰胆碱类神经递质、多巴胺类神经递质、谷氨酸（兴奋性氨基酸）类神经递质、氨基丁酸（抑制性氨基酸）类神经递质等；还有高压氧治疗。

4 选择舌针法的理论探讨

舌针是管正斋老中医根据《黄帝内经》中舌与脏腑经络关系的理论，结合祖传针法和自己数十年的临床经验创立的一种特殊针法[33]。管氏舌针的穴位主要有 24 个，分布在舌面及舌底部，现已成为舌针疗法的基础穴位[34]。其同眼针、头针等方法一样，已成为针灸学的重要组成部分。在管氏数代传承人的努力下，已建立起多个管氏针灸工作站及强大的学术团队，创新和发展了管氏针灸，形成了学术特点鲜明的管氏舌针学术体系。

舌针治病，渊源流长。舌针治病最开始出现在《黄帝内经》中。如《灵枢·终始》篇曰：“重舌，刺舌柱以镀针也。”《黄帝内经》奠定了舌针理论与实践的基础。

4.1 舌与经络、脏腑的关系

4.1.1 舌与经络的关系

足太阴脾经：连舌本，散舌下；足少阴肾经：挟舌本；任脉的承浆穴在舌本下；足太阴经别：贯舌中；足少阴经别及手少阳经筋系舌本；手少阴之络系舌本；足厥阴之络脉络于舌本，由此可见，经络系统中部分经络、经别、经筋、络脉与舌有直接的联系。从一些经络的穴位治舌病也可体现经脉与舌之间的关系,比如：手少阴心经的通里治舌强不语；足少阴肾经的涌泉治舌干、舌急失音；然谷治舌纵烦满；腹通谷治舌下肿难言，舌纵；足少阳胆经的头窍阴治舌本出血、舌强；督脉的哑门治舌缓、不能言、中风舌缓，风府治舌急难言；任脉的廉泉主舌下肿难言，舌中涎出等，这些也进一步说明舌与经络紧密相连。

4.1.2 舌与脏腑的关系

舌与心的关系：从心的生理功能上来说，心开窍于舌，心气通于舌，心主血脉，心主神明，那么气血的盛衰也会反应在舌上；心主导血脉，主神明，在于心气贯脉，

中国知网 https://www.cnki.net

推动血液，上至颅脑，濡养清窍，以助人思虑精明，致脑髓和利，如若不然，可致舌强、不语等。同时心为五脏六腑之大主，主宰五脏六腑，从而可以通过望舌来进行其他脏腑的诊断和治疗。舌与脾的关系：舌为脾之外候，根据脾的生理功能化生气血，气血的盛衰也会反应在舌上，此外胃气和舌苔的形成也有紧密联系。肝、肾、肺等脏腑通过经络和舌联系在一起，如若五脏六腑出现病理反应，可以通过观察舌像，也可以刺激相应穴位来是机体恢复。此外，根据历代医家对于舌面分属脏腑的划分，有以心、脾胃、肝胆、肾划分；也有以胃、上中下脘划分；还有以三焦划分，这也说明了脏腑和舌之间有着紧密联系。

4.2 管氏舌针的基础内容

4.2.1 舌穴分布的理论依据

《周易》是我国古代具有哲学思想的重要经典著作。管正斋正是在《周易》的基础上确定了管氏舌穴的分布、舌穴数的选定。

舌与全身脏腑经脉之间都有着直接和间接的联系。舌与机体是一个整体，舌包涵着《易经》全息论原胚。“太极生两仪”，舌分为舌面（阳）、舌下（阴）两部分。“两仪生四象”，阴阳化生为老阳、老阴、少阳、少阴“四象”。《易经》易理主要包含“象、数、易、占”。按易理老阳数是9，老阴数是6，少阳数是7，少阴数是8；少阴、少阳为初生，为阳，故分布舌面；舌下为阴，按“阴阳互根”和“阴升阳降”的理论，老阳分布舌下。少阳数是7，少阴数是8，少阳与少阴之和是15，故舌面穴位数是15个，按老阳数是9，故舌下穴位数是9个[16]。

舌穴的位置，以阴阳互根互用、阴阳消长转化为基础，体现了“阴升阳降”“五行相生相克”的中医理论。

4.2.2 舌针作用机理探讨

4.2.2.1 从经络、脏腑上论治

针灸治病就是通过针刺或艾灸腧穴，以疏通全身或局部的气血经络，调节脏腑功能，平衡阴阳，从而达到治疗疾病的目的。管氏舌针疗法属于微小针刺系统，其作用一样，通过刺激舌上的穴位来达到治疗疾病的目的。从各种医籍中记载可看出，在经络、经别、络脉中都和舌有着直接联系，如：足太阴脾经连舌本，散舌下；足少阴肾经挟舌本；足太阴经别贯舌中、足厥阴之络脉络于舌本等。而经络就像一座桥梁，把舌与各脏腑联系在一起，心、肝、肾、肺、脾胃都和舌有着联系。舌上分布着五脏六

中国知网 https://www.cnki.net

腑的穴位，相应脏腑的病理变化也会映射在舌上，通过针刺舌上各脏腑对应的穴位，从而达到脏腑和，经络畅，治疗疾病的作用。

4.2.2.2 生物全息学说

生物全息学说是张颖清于 1973 年提出来的，即每一个全息元都在不同程度上是整体的缩影[35]。舌是人体在舌上的一个缩影，因此，舌就是人体的一个特殊的全息胚结构，当人患病时，病变就会表现在舌上，通过刺激舌部的穴位，达到治病的效果[36]。

4.2.2.3 近脑学说

孙介光提出：在治疗方法上，治疗效果与距离脑的距离成正比，和腧穴近治作用一个道理，中风失语病位主要在脑、舌，而舌位于头的正中，具有丰富的体液及多种酶，同时对于外界的刺激可以很敏锐做出反应，针刺舌来治脑病无疑是距脑最近的，具有快速和良好的调节作用[37]。

4.2.2.2 神经学说

根据解剖学，舌面及舌底的神经较为丰富，这些神经各司其职，支配着舌的运动、管理味觉等。针刺舌体上的穴位，有可能是兴奋了舌体上神经的感受器，通过神经元的传送、汇聚到脑，再通过神经功能的调节作用达到治病的效果[34]。

5 选择舌针的依据

中风病的病机主要是阴阳失调、气血逆乱。病位在脑，与心、肝、脾、肾有着紧密联系，一旦遇到烦劳、房劳过度、情志不畅等诱因，阴阳失衡，气血逆乱而发。因此火、痰、瘀等病邪阻滞经络，扰及神明, 阴阳失调，阻闭舌窍是导致失语的基本病机[38]。舌针治疗中风正是通过疏调经络的气血、调整脏腑的阴阳、扶正祛邪，从而达到治疗疾病的效果。舌针除了具有针灸的常规特点外，还有舌针自身特点：

（1）人体口腔里的唾液含有多种酶物质，有自洁作用，发生感染的几率很低；

（2）操作安全，患者会感到微痛，接受度高；

（3）舌针只需在舌部进行点刺，免去了常规针刺留针时间长的特点；

（4）反应快、见效快，疗效稳定、持久，中远期效果好；

（5）舌诊与治疗融为一体。

我的导师通过多年对舌针的应用实践中发现，舌针对于中风后遗留的失语、吞咽困难等疾病的治疗，有着极佳的疗效。舌针的适应症的范围较广，舌和五脏六腑、经络系统之间有着密不可分的联系，当处于正常生理状态下,脏腑及气血津液一定会表

中国知网 https://www.cnki.net

现在舌上；当人处于疾病状态下时，针刺舌上的穴位,可治疗全身各系统的病证，尤其是在舌疾及脑部疾病方面疗效显著，例如：失语症、吞咽困难、小儿脑瘫、郁病等。此外，这也是对名老中医管正斋教授的学术思想的传承。

前期研究表明，管氏舌针治疗中风后失语有着独特的疗效。李群等[39]在治疗中风病人时，治疗 4 个疗程后，发现：舌针联合体针的疗效显著，比单一疗法效果好，经过舌针治疗后，血液的黏稠度较之前降低，中风病人的微循环也得到了一定改善，可以有效防止血栓的形成，进一步达到修复脑组织的作用。申涛等人[40]使用舌针治疗 32 例中风后遗症，最后总有效率达 97%。郭翠萍[41]治疗中风后失语患者的过程中，采用管氏舌针，2～5 个疗程过后，达到了非常乐观的治疗效果。王花蕾等人[42]采用管氏舌针治疗中风后运动性失语患者，10 周后观察结果，管氏舌针对于治疗失语有显著疗效。李莉等人[43]采用管氏舌针治疗 60 例中风后失语患者，治疗 2 个疗程后，舌针组的效果明显优于对照组，证明舌针治疗失语患者的疗效显著。

6 言语康复训练的益处

目前治疗失语的康复治疗方案中较为常用的是 Schuell 言语康复训练法，它可以根据患者失语病情严重程度的评估，依据患者自身情况，量身定制一个治疗计划。它的作用点在于着重提高语言功能，主要通过刺激听觉，医师反复使用强有力的语言刺激，然后根据患者的反应再加以刺激，这样就会形成一条通路，激发患者大脑语言中枢系统的反应，从易到难，由浅入深，并在不同的治疗阶段去评估患者的病情，根据病情的严重程度去调整患者的治疗方案，以达到促进患者的语言再建和恢复。经过大量的临床研究观察，该法能显著提高患者的听说读写能力，已经成为公认治疗失语症的有效方法。当患者中风后出现失语时，医师要尽早对患者开始言语康复训练，这将有助于患者的恢复。熊雅红等人[44]治疗失语时选取失语症患者 142 例，4 个月后观察疗效，得出结论：常规内科治疗加上 Schuell 法的总有效率高于常规内科治疗，该法能显著提高治疗效果，使患者的认知功能得到明显的改善，且越早进行言语康复训练，疗效也会越明显，从而更大限度上改善患者的生活质量[44]。

总之，在治疗中风后动性失语患者的过程中，言语训练非常有助于患者的言语恢复，对于提高患者的语言功能有着明显的促进作用，且训练时间越早越好。

7 管氏舌针与言语康复训练相结合的优势

管氏舌针联合言语康复训练治疗中风后遗有运动性失语的患者，这不单单是针刺

中国知网 https://www.cnki.net

效应与言语康复治疗的单纯累加，而是取二者之长，对中风后运动性失语症起着积极的治疗作用。阚俊微等[45]通过对上千例失语患者使用不同方法治疗的治疗效果进行Meta分析后发现：舌针与体针及药物治疗中风后失语患者相比较，舌针的临床疗效更好。张勇等[46]通过对数篇文献的上千例中风失语症患者的有效率、听理解能力、阅读能力、书写能力等方面进行Meta分析后，得出结论：针刺对于治疗中风失语症的疗效较为突出，并且针刺联合体针、头针、舌针、言语康复训练、中药等方法的临床疗效比单纯针刺、言语康复显著很多。

中风病人在寻求中医针灸治疗过程中，不仅能治疗患者肢体功能障碍，还能改善患者其他功能障碍，比如言语功能、吞咽功能等后遗症，这可以激发了病人对于恢复疾病的信念，将会促进病人的配合度和依从性，从而缩短恢复病程，整体提高患者的各项功能指标。并且言语康复训练疗法主要是连续刺激患者的听说读写等功能，这恰巧是针刺治疗无法完成的，而舌针点刺不留针、操作方便、安全有效，疗效稳定、持久，患者接受度高；因此，两种方法的联合应用为治疗中风后运动性失语症提供了一种新思路，可以更好应用于临床，造福于患者及家庭。

8 疗效分析

8.1 两组患者治疗前后复述评分比较

对照组及舌针组治疗前后分别比较，P均＜0.001，治疗后两组组间比较，P＜0.001；两组治疗前后复述评分的差值比较，P＜0.001。以上结果表明：经过两种方法治疗后，患者的复述功能的评分均有提高，并且舌针组效果优于对照组。

8.2 两组患者治疗前后谈话评分比较

对照组及舌针组治疗前后分别比较，P均＜0.001；治疗后两组组间比较，P=0.003（＜0.05）；两组治疗前后差值比较，P＜0.001。以上结果表明：经过两种方法治疗后，患者的谈话功能的评分均有提高，并且舌针组的效果优于对照组。

8.3 两组患者治疗前后理解评分比较

对照组及舌针组治疗前后分别比较，P均＜0.001；治疗后两组组间比较，P=0.598（＞0.05）；两组治疗前后差值比较，P=0.412（＞0.05）。以上结果表明：经过两种方法治疗后，患者的理解功能的评分均有提高，但两组对于提高理解评分的疗效无差异。

中国知网 https://www.cnki.net

8.4 两组患者治疗前后命名评分比较

对照组及舌针组治疗前后分别比较，P 均＜0.05；治疗后两组组间比较，P=0.038（＜0.05）；两组治疗前后差值比较，P＜0.001。以上结果表明：经过两种方法治疗后，患者的命名功能的评分均有提高，并且舌针组的效果优于对照组。

8.5 两组患者治疗前后的言语功能分级比较

对照组及舌针组治疗前后分别比较，P 均＜0.05；两组患者治疗后 BDAE 言语功能分级比较，P值=0.021＜0.05。以上结果表明：两种治疗方法均能提高中风后运动性失语患者的言语功能；舌针组的效果优于对照组。

8.6 疗效评价

按照疗效评价标准，对照组总有效率为 67.65%，舌针组为 88.24%。经卡方检验后，P值=0.026（＜0.05），具有统计学意义，表明舌针组总有效率高于对照组。

中国知网 https://www.cnki.net

结 论

本课题将中风后运动性失语患者按照随机分为 2 组。2 组均予西医基础及基础针刺治疗，对照组采用言语康复训练治疗，舌针组在对照组基础上联合舌针治疗。2 个疗程后，通过比较两组患者治疗前后 4 项语言功能的评分、失语症严重程度分级（BDAE）、疗效评价、安全性及不良反应，可得出以下结论：

（1）舌针联合言语康复训练与言语康复训练均能提高中风后运动性失语患者的语言功能，均有良好的效果；

（2）舌针联合言语康复训练治疗中风后运动性失语的临床疗效优于言语康复训练，对于提高患者的复述、谈话、命名功能，改善病人失语严重程度的效果更为显著，并且安全、操作简单方便，临床值得推广和应用。

中国知网 https://www.cnki.net

不足与展望

（1）语言功能的重建、恢复与治疗时间长短有很大关系，本课题由于经费、人力、病人住院天数的限制，并且患者大部分都是云南省本地人，存在一定的地域限制，同时本研究的纳入样本观察数量较少，疗程仅有 2 周，疗程相对较短，也没有后期随访，此外，疗效评估使用的是量表，缺乏客观评价数据。以后将完善研究方案，开展大样本、多中心的研究。

（2）中医学里针对失语的证型分类并未有统一、明确的诊断标准，本课题仅针对中风后运动性失语患者研究，研究的类型较为单一，日后可再细化研究类型，比如：设定某一证型、选择感觉性失语或者混合性失语等。

（3）本课题是从临床研究观察的角度去探讨舌针的作用，舌针的机理研究较表浅，缺少动物实验手段结合细胞和基因水平的实验，日后有待从细胞、基因方向去研究舌针的疗效机制及早期介入舌针治疗的优势。

（4）近年来，在广大中医工作者的努力下，治疗中风后运动性失语患者已经取得了非常显著的进步，我们仍需要不断完善、提高，更加深入对该病的研究，充分发挥针灸的特色和优势。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]彭斌,吴波.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(09):666-682.

[2]吴兆苏,姚崇华,赵冬.我国人群脑卒中发病率、死亡率的流行病学研究[J].中华流行病学杂志,2003(03):71-74.

[3]张通.中国脑卒中康复治疗指南(2011完全版)[J].中国康复理论与实践,2012,18(04):301-318.

[4]陈改平,杨郁文,倪斐琳,等.杵针疗法对中风运动性失语患者语言康复的研究[J].上海针灸杂志,2018,37(07):742-745.

[5]赵妍妍,马建军.脑卒中后运动性失语症的研究进展[J].中国实用神经疾病杂志,2016,19(12):72-73.

[6]齐丹青,姚济荣,刘宇,等.首发脑卒中致残后抑郁影响因素调查[J].中国全科医学,2014,17(18):2115-2117.

[7]李晓琳,常静玲.论中风后失语辨证中的“痰”与“窍”[J].中华中医药杂志,2016,31(09):3450-3454.

[8]Ostwald S K, Davis S, Hersch G, et al.Evidence-Based Educa-tional Guidelines for Stroke Survivors After DischargeHome[J].J Neurosci Nurs,2008,40(3):173-191.

[9]李世龙,顾兆军.针刺治疗中风后失语症的研究概况[J].陕西中医,2015,36(04):511-513.

[10]王荫华.汉语失语症失语类型的鉴别诊断流程(二)[J].中国康复理论与实践,1997(02):57-59.

[11]王荫华.汉语失语症失语类型的鉴别诊断流程(一)[J].中国康复理论与实践,1997(01):10-12.

[12]中风的诊断依据、证候分类、疗效评定——中华人民共和国中医药行业标准《中医内科病证诊断疗效标准》(ZY/T001.1-94)[J].辽宁中医药大学学报,2016,18(10):16.

[13]杨骏,高树中,赵吉平等.针灸治疗学[M].3版.北京:中国中医药出版社,2012:42-43.

[14]陈顺荣,管傲然,管薇薇等.管遵惠学术经验撷菁[M].昆明:云南科技出版社,2015:43-47.

[15]王丽梅,王左生.言语治疗技术[M].2版.北京:人民卫生出版社,2014:45.

[16]陈顺荣,管傲然,管薇薇等.管遵惠学术经验撷菁[M].昆明:云南科技出版社,2015:43-47.

中国知网 https://www.cnki.net

[17]刘清国,胡玲,谭奇纹等.经络腧穴学[M].3 版.北京:中国中医药出版社,2012.

[18]Candidate M P,Co-director L W B P,Ba G L D.Systematic review of the quality of clinical guidelines for aphasia in stroke management[J].Journal of Evaluation in Clinical Practice,2013,19(6):994-1003.

[19]高士宗.黄帝素问直解[M].北京:中国医药科技出版社,1980:24.

[20]吴谦.医宗金鉴心法集要[M].沈阳.辽宁科学技术出版社,2007:6.

[21]李顺保.宋太医局诸科程文格注释[M].北京.学苑出版社,2007:41.

[22]李用粹,吴唯.证治汇补[M].北京.中国中医药出版社,2008:3.

[23]张志聪.黄帝内经素问集注[M].浙江书局,2014.

[24]郭锋.基于数据挖掘技术研究蔡圣朝教授治疗中风后运动性失语的学术经验[D].合肥:安徽中医药大学,2020.

[25]双晓萍,陈乞,谭子虎.谭子虎教授针药结合治疗中风后失语[J].吉林中医药,2015,35(08):782-784.

[26]王新志,王海军,李燕梅.中风失语研究述评[J].中医杂志,2005(01):68-70.

[27]Kasselimis D S,Simos P G,Peppas C,et al.The unbridged gap between clinical diagnosis and contemporary research on aphasia:A short discussion on the validity and clinical utility of taxonomic categories[J].Brain&Language,2017,164:63-67.

[28]焦黛妍,邓海鹏,张若尘,等.脑卒中患者失语症发生的影响因子及预后[J].中国听力语言康复科学杂志,2019,17(05):370-373.

[29]蒋智芳.调神理气针刺及舌三针对脑卒中运动性失语的影响[D].广州:广州中医药大学,2017.

[30]张建伟.针刺早期干预中风后运动性失语疗效观察[J].世界中医药,2014,9(10):1349-1351.

[31]张高震.颈项九针加言语康复训练治疗卒中后运动性失语口语表达障碍的临床研究[D].合肥:安徽中医药大学,2019.

[32]Hamilton R H,Chrysikou E G,Coslett B.Mechanisms of aphasia recovery after stroke and the role of noninvasive brain stimulation[J].Brain&Language,2011,118(1-2):40-50.

[33]谭保华,管遵惠.管氏舌针的临床运用[J].云南中医中药杂志,2003(06):1-2.

[34]管傲然,管薇薇,李群,等.舌针治疗作用机理的探讨[J].时珍国医国药,2016,27(04):914-915.

中国知网 https://www.cnki.net

[35]张颖清.生物全息诊疗法[M].山东大学出版社,1987:92.

[36]张勇.从全息律探讨中医舌诊原理[J].中国中医药现代远程教育,2012,10(03):16-17.

[37]孙介光,孙雪然.舌针疗法[J].中国针灸,2010,30(04):38.

[38]曲爱华.中风失语的病机分析[J].中国中医基础医学杂志,2009,15(07):489-490.

[39]李群,王祖红,叶建,等.舌针为主治疗中风临床观察[J].中国针灸,2005(11):72-74.

[40]申涛.管氏舌针的临床应用体会[J].光明中医,2006(09):21-22.

[41]郭翠萍.管氏舌针治疗中风失语56例[J].中国针灸,2008(02):127-128.

[42]王花蕾,王艳梅.管氏舌针结合语言康复训练治疗脑卒中运动性失语30例[J].云南中医中药杂志,2017,38(12):54-55.

[43]李莉,王祖红,易荣,等.管氏舌针治疗缺血性中风后失语30例临床观察[J].云南中医中药杂志,2019,40(12):38-41.

[44]熊雅红,李彬,黄艳丽.Schuell法语言训练对失语症患者的治疗价值[J].中国听力语言康复科学杂志,2019,17(04):283-286.

[45]阚俊微,王成伟,邱玲.舌针治疗中风失语症疗效的系统评价[J].针灸临床杂志,2013,29(05):51-55.

[46]张勇,傅立新,朱原,等.针刺治疗中风失语症疗效的系统评价[J].针灸临床杂志,2014,30(11):62-65.

中国知网 https://www.cnki.net

文献综述

针刺治疗中风后运动性失语的研究进展

摘要：失语症是中风后常见的后遗症之一，阻碍患者的生活水平的提高，降低患者的生活质量和幸福感，给家庭及社会带来极大负担。通过对近6年针刺治疗该病的相关文献进行检索，对其进行一个归纳讨论后，发现针灸的疗效显著，主要以联合疗法为主，针刺（舌针、头针等）联合其他特殊疗法（比如：言语康复训练、电针、放血、艾灸以及高压氧法等），可以明显改善中风后运动性失语患者的言语功能，并提高患者的生活质量，为各位医者提供良好的治疗思路。

关键词：中风；运动性失语；针刺，联合疗法

在社会老龄化进程不断加剧的背景下，中风的发病率逐年上升，其中约30%的中风患者会出现语言功能的障碍，并且运动性失语是最常见的类型，主要是由于大脑半球语言及其相关中枢受到器质性损伤，进而降低语言成分解码及编码能力，患者症状多表现为听、说、读、写能力障碍，极大的限制了其与家人及社会的正常沟通交流，严重影响患者的融入社会的能力及生存质量[1]。所以应尽早干预患者出现的功能障碍，选取合适、疗效明显、远期效果佳的治疗方法，将会极大促进患者的语言功能恢复能力，对于减少该病的致残率和提高患者的生活幸福感及质量有着非常大的意义。

1 体针

郭思伶[2]采用林国华教授经验穴位膻中配间使穴治疗失语患者，连续治疗2周后，治疗组的总有效率为：70.00％，得出结论：以膻中配间使穴治疗提高患者的语言功能的效果更佳，患者接受度较高。

王儒蒙等[3]使用针刺通里穴加上常规穴位治疗中风后运动性失语患者，2个疗程后，发现针刺通里穴的治疗组对于谈话、复述、命名能力的疗效比对照组好。

联合其他针法：蒋智芳[4]使用调神理气针刺联合舌三针疗法，观察对运动性失语患者的治疗效果，8周后观察疗效，发现在患者功能性语言沟通能力及言语流利性、复述、听理解方面，调神理气针刺配合舌三针的临床疗效更显著。

中国知网 https://www.cnki.net

联合艾灸：王自励[5]采用醒脑开窍针法配合艾灸温和灸神阙穴治疗失语患者，治疗 4 周后，得出结论：该法的总体临床疗效更显著，值得临床进一步研究及推广。

联合五行音乐：张虎等人[6]纳入 120 例失语患者，60 例患者给予针灸治疗，剩下 60 了患者在针灸基础上联合中医五行音乐疗法，治疗 4 周后，发现：针刺联合五行音乐疗法能明显提高失语患者的语言能力并改善焦虑。

联合中药：林逢春[7]采用针刺联合自拟通络汤治疗脑梗死后运动性失语患者，其有效率可达 95%，由此可见针刺联合中药效果可观。卢英等人[8]采用针刺联合自拟中药汤剂活血开窍通络方治疗，发现该法可明显改善患者语言功能、降低神经功能缺损和血液粘稠度，疗效优于单用语言康复训练治疗。

联合低频重复经颅磁刺激：杨泉等人[9]治疗脑梗死运动性失语患者时，使用针灸联合低频低频重复经颅磁刺激治疗，治疗之后发现该法疗效更佳，值得推广。

联合穴位贴敷：郭锋等人[10]在治疗运动性失语患者时，采用在针刺及言语康复训练基础上联合解语膏穴位贴敷治疗，治疗 4 周后发现：其总有效率可达 90.0%，针刺联合解语膏穴位贴敷可明显提高失语患者的言语能力，疗效更显著。

2 舌针

目前临床中常用的舌针以“靳氏舌三针”、“管氏舌针”为主。舌针对于治疗失语的患者有着非常显著的效果，通过针刺舌体的穴位，可刺激到舌面及舌根部的末梢神经，通疏通经络，通舌窍，从而改善患者的言语功能。

祝勇强[11]治疗 66 例中风后运动性失语的病人时，使用舌三针法，在行手法过程中嘱患者训练发音及讲话，与只行提插捻转法针刺治疗对比，治疗 4 周后，发现舌三针运动针法疗效显著。

刘群霞[12]在治疗中风后失语的患者时，选取舌三针，配穴为哑门、通里，金津、玉液点刺出血，有很好的效果。

许慧倩等人[13]采用舌针治疗脑卒中后运动性失语，治疗 4 周后，发现：舌针组总有效率明显高于言语组。

李莉等人[14]采用管氏舌针治疗缺血性中风后失语患者，治疗 2 个疗程，发现管氏舌针的效果优于常规针刺。

联合中药：潘波[15]采用舌针配合解语丹治疗中风后失语患者，发现：舌针配

中国知网 https://www.cnki.net

合解语丹有显著效果，其总有效率明显高于另一组。

联合颅底七针：李丽等人[16]在治疗缺血性脑卒中后失语症的过程中采用管氏舌针联合颅底七穴，治疗4周后，发现管氏舌针联合治疗组总有效率为86.67%优于对照组，管氏舌针结合颅底七穴的效果更佳。

联合言语康复训练：王琦等人[17]在治疗卒中后轻中度运动性失语的过程中，采用常规卒中基础治疗及康复、Schuell刺激疗法联合改良型舌针治疗，治疗6周后，发现改良型舌针配合Schuell刺激疗法效果更佳。杨彬彬等人[18]采用舌针联合言语训练观察治疗脑梗死后运动性失语患者的效果如何，治疗3个月后，发现：舌针联合言语训练治疗的总有效率高于语言康复训练。王涛然等人[19]在治疗失语患者过程中，采用舌针联合语言疗法，4周后发现舌针联合语言疗法总有效率90.0%高于单纯语言疗法的总有效率，舌针配合语言疗法效果更佳。

联合穴位贴敷：徐婉月等人[20]在治疗中风后运动性失语的临床研究中，将靳氏舌三针治疗法与穴位敷贴联合靳氏舌三针作比较，治疗4周后，得出结论：穴位敷贴联合舌针疗效更显著。

3 电针

盛国滨等人[21]采用电针刺激于氏颞区与传统针刺比较治疗中风后非流畅杜失语的临床疗效，发现电针组总有效率高于传统针刺组，说明电针疗效更佳。

联合言语训练：马艳平[22]、汪瑛[23]、孙捷[24]、林勉[25]等人采用头电针联合言语康复训练的方法治疗失语患者，均得出结论：头电针联合语言训练改善失语患者的语言功能的效果较为优秀，疗效比单用语言训练好，还能降低NIHSS评分、全血黏度、红细胞聚集指数、红细胞沉降及纤维蛋白原，可以改善神经功能及血流动力学。

联合经颅磁刺激：彭拥军等人[26]研究在不同频率的重复经颅磁刺激下，电针治疗中风后患有运动性失语患者的效果如何，他将患者随机分为高频组、低频组、对照组。三组均予相同的基础治疗和言语康复治疗，高频组予5Hz的高频刺激左侧半球Broca区联合电针；低频组予1Hz的低频刺激右侧半球Broca对应区联合电针；对照组予电针，治疗4周，发现：电针结合高频或低频重复经颅磁刺激具有良好的疗效。

钟悦等人[27]通过纳入15个研究的多名失语患者的10多种疗法进行对比，进

中国知网 https://www.cnki.net

行了对针灸有效性 Meta 分析，得出结论：头电针+康复的疗效最佳，其次是针灸综合疗法+康复，最后是康复治疗。

4 头针

中风后失语症病位主要在脑窍和舌窍，头为诸阳之会，故头与脏腑经络有着密切关系。有研究表明：头针通过刺激大脑皮层相应的功能区对应的头皮来治疗神经功能受损引起的各种症状[28]。经查阅文献发现，目前单独采用头针治疗失语较少，大部分研究均是头针联合其他治疗，比如言语康复训练、电针、舌针、梅花针等。

田思思[29]采用头针巨刺法治疗卒中后的失语患者，疗程结束后发现，取患者健侧的言语一区、四神聪、百会、廉泉、哑门的治疗组的疗效要高于仅针刺患者患侧的言语一区的对照组。

联合言语康复训练：胡舫[30]、赵黎婷[31]、刘薇[32]、谢静霞[33]、金荣祥[34]等人采用头针结合语言康复训练治疗失语患者临床效果较好,可促进患者失语症状的恢复,值得临床应用。

联合中药：何丹[35]、陈清祥[36]等人使用补阳还五汤加减联合头针治疗中风失语患者，可明显改善患者的神经功能缺损及提高言语功能，临床疗效较好。

联合梅花针：李亚东[37]在治疗失语患者过程中使用头针联合梅花针叩刺，同时在再加上语言康复训练，治疗 1 个月后，发现头针联合梅花针叩刺同时再联合上语言康复训练的三联法对于改善患者语言功能的效果显著。

联合舌三针：刘兰兰等人[38]在临床中采取头针联合舌三针治疗中风后运动性失语症，与只采用常规体针针刺疗法比较，治疗 30 天后,得出结论：头针与舌三针联合治疗在减轻病情及神经功能受损方面有着很明显的效果。

联合高压氧：丁晓燕等人[39]将失语患者随机分为两组,每组 25 例，2 组均给予常规药物治疗、言语训练、头针治疗,联合治疗组加上高压氧治疗，3 个疗程后,得出结论：高压氧联合头针与常规的康复训练结合的效果更佳。

5 颈项九针

张高震[40]治疗 60 例卒中后运动性失语口语表达障碍病的患者时,采用颈项九针加言语康复训练与言语康复训练比较疗效，共治疗 4 个周期后，得出结论：在改善病人失语严重程度、缓解抑郁状态的效果方面，颈项九针加言语康复的效

中国知网 https://www.cnki.net

果更胜一筹。

6 刺络放血疗法

王妤函[41]在临床中治疗失语，使用了点刺放血疗法，选取金津、玉液点刺放血，治疗14天后，发现点刺放血 可以明显改善失语患者的谈话、复述、命名项评分，效果优于普通针刺组。

7 其他针法

7.1 通督交泰针法

贾力等人[42]选取 60例失语患者纳入研究，采用两种治疗方案，一种是使用通督交泰针法配合言语训练治疗，另一种是采用常规体针加言语训练治疗。治疗4周后观察言语功能评分、言语功能疗效、抑郁评分和焦虑评分，得出结论：通督交泰针法配合言语训练治疗中风后失语症效果显著，能明显促进患者的言语功能的恢复，提高语言及交流能力，同时还可缓解患者抑郁焦虑情绪，使患者更快恢复。

7.2 “金钩钓鱼”开窍解语针法

任超展等人[43]采用“金钩钓鱼”开窍解语针法联合疗法治疗中风后运动性失语患者，将患者随机分为两组各35 例。两组都予基础治疗，对照组加言语康复训练；观察组在言语训练的基础上予“金钩钓鱼”开窍解语针法治疗，穴取哑门、金津、玉液、合谷等，共治疗 4 周，得出结论：“金钩钓鱼”开窍解语针法联合言语康复训练可提高中风后运动性失语患者的语言功能，疗效更佳。

7.3 通窍开音针法

李文茜等人[44]采用通窍开音针联合语言康复训练治疗中风后运动性失语，与常规针刺治疗法比较，疗程结束后发现：通窍开音针联合语言康复训练更能有效加快患者语言功能恢复，明显降低患者的ET水平，升高患者血清中的CGRP水平，更利于后续恢复。

7.4 梅花针叩刺联合调神通络法

刘玲玲等人[45]使用梅花针叩刺联合调神通络法治疗缺血性脑卒中后运动性失语患者，治疗2个疗程后，得出结论：调神通络法（头针加体针）联合梅花针叩刺的疗效比调神通络法显著。

中国知网 https://www.cnki.net

7.5“开瘖五穴”针刺法联合语言康复训练

杨娅等人[46]采用“开瘖五穴”针刺法联合语言康复训练治疗失语患者，与传统针刺法比较，3 个疗程后对比疗效，发现：针刺“开瘖五穴”结合语言康复训练能明显促进患者语言功能恢复，效果更好。

7.6“益脑调神”针灸疗法

林智[47]采用“益脑调神”针灸疗法治疗中风运动性失语，与言语康复训练治疗比较临床效果，疗程结束后，发现“益脑调神”的显效率、有效率均明显高于单纯言语训练。

8 小结

近年来，在广大中医工作者的努力下，针灸治疗中风后运动性失语患者已经取得了很大进展，治疗方法也多样化。经分析以上临床研究，综合疗法效果优于单一治疗。目前常用的针刺方法主要以头针、舌针为主，常联合其他疗法（比如：言语康复训练、电针、放血、艾灸以及高压氧法等），患者及家属对这些疗法的接受度也越来越高，具有很高的临床应用价值，同时多种方法联合使用也是未来发展的趋势。但是目前研究中存在许多不足：（1）大部分都是从临床研究观察的角度去探讨疗效，缺少动物实验手段结合细胞和基因水平的实验去探讨其治疗机制；（2）没有统一标准的评价指标，尤其是中医对于中风的疗效评判治疗，并且主要以量表为主，缺乏客观的评价指标；（3）临床研究的样本量较小，主要是以开展研究的医院为中心，缺乏大样本、多中心、跨领域的研究。在今后的临床研究中，希望能够弥补以上不足。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 芮锦伟,区淑娟,权元鼎,等.圣愈汤联合针刺对缺血性脑卒中后失语症患者语言功能及生活质量的影响[J].现代中西医结合杂志,2020,29(35):3920-3924.

[2] LING郭思伶KWOK SZE.针刺膻中、间使穴治疗中风后运动性失语症的临床研究[D].广州:广州中医药大学,2019.

[3] 王儒蒙,焦杨.针刺通里穴治疗运动性失语的临床疗效观察[J].实用中西医结合临床,2018,18(01):135-136.

[4] 蒋智芳.调神理气针刺及舌三针对脑卒中运动性失语的影响[D].广州:广州中医药大学,2017.

[5] 王自励.醒脑开窍针法配合艾灸神阙治疗中风运动性失语疗效观察[D].广州:广州中医药大学,2018.

[6] 张虎,张大尉,董继革.针灸配合中医五行音乐疗法治疗卒中后运动性失语伴焦虑病人的临床研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2017,15(24):3194-3196.

[7] 林逢春.针刺联合自拟通络汤治疗脑梗死后运动性失语临床研究[J].光明中医,2020,35(18):2878-2880.

[8] 卢英,廖炼炼,梁辉.针药并用联合康复训练对脑卒中后运动性失语患者语言功能、神经功能及血液流变学的影响[J].湖南中医药大学学报,2019,39(09):1138-1142.

[9] 杨泉,陈敬君,鲍晓,等.针灸结合低频重复经颅磁刺激治疗脑梗死运动性失语的临床效果[J].中国当代医药,2020,27(12):49-52.

[10]郭锋,朱才丰,陈雪艳,等.解语膏穴位贴敷辅助治疗脑卒中后运动性失语30例临床观察[J].甘肃中医药大学学报,2019,36(06):66-69.

[11]祝勇强.舌三针运动针法治疗脑卒中后运动性失语的临床观察[D].广州:广州中医药大学,2018.

[12]王萍,刘晓焕,吴瑞娜.刘群霞以“醒脑开窍,通舌利咽”法舌针为主治疗中风后言语不利经验浅析[J].中医药临床杂志,2018,30(03):415-417.

[13]许慧倩,陈洁.舌针治疗针对性改善运动性失语患者各项言语能力的临床观察[J].临床研究,2020,28(11):103-104.

[14]李莉,王祖红,易荣,等.管氏舌针治疗缺血性中风后失语30例临床观察[J].云南中医中

中国知网 https://www.cnki.net

药杂志,2019,40(12):38-41.

[15]潘波.舌针配合解语丹治疗中风后失语患者的临床疗效分析[J].中国实用医药,2018,13(09):115-116.

[16]李丽,黄培冬,栾莎,等.管氏舌针结合颅底七穴治疗缺血性脑卒中后失语症的临床研究[J].中华中医药杂志,2020,35(11):5851-5854.

[17]王琦,徐中菊.改良型舌针配合 Schuell 刺激疗法治疗卒中后轻中度运动性失语临床观察[J].河北中医,2018,40(04):589-592.

[18]杨彬彬,乔菲,陈铎.奥瑞姆自理模式下舌针联合语言康复训练治疗脑梗死后运动性失语疗效分析[J].海南医学,2018,29(03):316-319.

[19]王涛然,刘群,赵丽侠,等.舌针配合语言疗法治疗中风运动性失语的疗效观察[J].山东中医杂志,2016,35(01):36-37.

[20]徐婉月,蔡圣朝.穴位敷贴联合舌针治疗中风后运动性失语 60 例[J].中医药临床杂志,2016,28(09):1275-1277.

[21]盛国滨,尹晓娜,唐英.电针颞区治疗中风后非流畅性失语的临床观察[J].中国中医药科技,2015,22(02):235.

[22]马艳平,杨凯.头电针联合语言训练治疗脑卒中运动性失语的疗效观察[J].按摩与康复医学,2020,11(11):62-64.

[23]汪瑛,汪节,陈少飞.电针配合 Schuell 刺激法治疗中风后失语的临床研究[J].湖南中医药大学学报,2020,40(04):465-468.

[24]孙捷,金晶晶,李亚楠.头针联合电针治疗缺血性脑卒中后失语症临床观察[J].光明中医,2019,34(23):3637-3638.

[25]林勉,林妙君.头电针配合言语训练治疗脑卒中后失语的效果[J].中国当代医药,2019,26(19):62-65.

[26]彭拥军,吕鹤群,乔玉,等.电针结合不同频率重复经颅磁刺激治疗脑卒中后运动性失语临床研究[J].辽宁中医药大学学报,2020,22(10):1-4.

[27]钟悦,秦玮珣,王志婕,等.针灸在卒中后失语康复过程中有效性的网状 Meta 分析[J].辽宁中医杂志:1-19.

[28]庄惠娟.头体针配合语言康复训练治疗脑卒中后失语症[J].针灸临床杂志,2010,26(09):27-29.

[29]田思思.头针巨刺法治疗运动性失语的临床研究[D].长春:长春中医药大学,2016.

中国知网 https://www.cnki.net

[30]胡舫,赵涌琪.头针结合语言康复训练治疗脑卒中运动性失语效果观察[J].临床合理用药杂志,2020,13(31):143-144.

[31]赵黎婷,李谊深,和莹,等.头针结合言语训练对脑卒中后运动性失语社区康复方案的疗效观察[J].中国社区医师,2020,36(27):92-93.

[32]刘薇,朱文宗,宋丰军,等.头针配合言语功能训练治疗中风后运动性失语临床研究[J].新中医,2020,52(06):132-134.

[33]谢静霞,陈庆亮,吴倩.头针结合言语训练治疗运动性失语的疗效观察[J].中医外治杂志,2020,29(01):32-33.

[34]金荣祥,张成,倪红雷,等.头针联合语言康复训练对脑卒中后运动性失语症患者的疗效研究[J].新疆医科大学学报,2018,41(12):1503-1507.

[35]何丹,王建波.补阳还五汤加减联合头针治疗缺血性中风失语气虚血瘀证的疗效研究[J].辽宁中医杂志,2018,45(07):1488-1491.

[36]陈清祥,刘洋洋,杨进贵,等.补阳还五汤结合头针对脑梗死后运动性失语的影响[J].实用中西医结合临床,2017,17(12):4-6.

[37]李亚东.头针与梅花针叩刺结合语言康复训练治疗缺血性中风失语疗效观察[J].山西中医,2017,33(04):37-38.

[38]刘兰兰,黄兵,宋曼萍.头针联合舌三针治疗脑卒中后运动性失语症分析[J].长春中医药大学学报,2020,36(05):944-947.

[39]丁晓燕,周宏图,范宏娟,等.高压氧联合头针治疗脑卒中后运动性失语疗效观察[J].中华航海医学与高气压医学杂志,2020(02):184-187.

[40]张高震.颈项九针加言语康复训练治疗卒中后运动性失语口语表达障碍的临床研究[D].合肥:安徽中医药大学,2019.

[41]王妤函.金津、玉液点刺放血治疗中风后失语的临床研究[D].乌鲁木齐:新疆医科大学,2020.

[42]贾力,刘东,白洁,等.通督交泰针法配合言语训练治疗中风后失语症的研究及对焦虑抑郁影响[J].心理月刊,2020,15(19):207-208.

[43]任超展,吕汐妍,张茜娟,等."金钩钓鱼"开窍解语针法联合言语康复训练治疗中风后运动性失语疗效观察[J].中国针灸,2020,40(10):1037-1041.

[44]李文茜,虞军,王春燕,等.通窍开音针联合语言康复训练治疗中风后运动性失语临床研究[J].针灸临床杂志,2020,36(07):16-20.

中国知网 https://www.cnki.net

[45]刘玲玲,李骁飞,马本绪.梅花针叩刺配合调神通络法治疗缺血性脑卒中后运动性失语 30 例临床观察[J].中国中医药科技,2016,23(05):613-614.

[46]杨娅,刘广霞,徐洋,等.针刺“开瘖五穴”结合语言康复训练治疗缺血性脑卒中后运动性失语临床观察[J].安徽中医药大学学报,2019,38(02):48-51.

[47]林智.益脑调神针灸疗法对中风运动性失语的治疗效果探讨[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(55):338-340.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

附录一：

<table>
<tr><td colspan="4">简化版《汉语失语症检查法》量表</td></tr>
<tr><td>姓名：</td><td>年龄：</td><td rowspan="4">治疗前得分</td><td rowspan="4">治疗后得分</td></tr>
<tr><td>性别：</td><td>职业：</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">一、谈话（6分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">提问：
1.您叫什么名字？2.多大年纪?3.往在哪里?4.做什么工作（或退休前做什么工作）?5.请简单说说怎么不舒服 6.系列语言：数1-21。
以上各项记作1分，0分为哑，1分为刻板重复，2分为非流利型，3分为流利型，4分为中间型，5分为正常。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">二、复述（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.口
2.九十五
3.四个四十七
4.百分之八十八
5.手和窗户
6.狗和机器
7.乌鲁木齐和呼和浩特
8.一个大花碗叩一个大花蛤蟆
9.他刚一进口就又下雨又打雷
10.所机全微他合
以上每项记作1分。</td><td></td><td></td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

三、理解（15 分）		
（1）执行指令。 1、窗户； 2、灯；3、鼻子；4、肩膀；5、进这个房间； 6、能躺下睡觉的地方；7、鼻子、肩膀和下巴；8、用右手摸左耳（或左手摸右耳）9、拿起钢笔碰一下铅笔；10、把纸翻过来，把笔放在下面。		
（2）是/否题。 1、您的名字是（说病人的名字）？2、这是钢笔吗？3、您吃早饭了吗？4、这里是旅馆吗？5、古月份下雪吗？		
以上每项记作 1 分。 理解总分：		

中国知网 https://www.cnki.net

四、命名（17分）		
（1）物品（10分）：1、钢笔 2、耳朵 3、鼻子 4、表带 5、胳膊肘 6、眼睛架 7、袖子 8、领子 9、拇指 10、中指		
（2）列名（1分）：说蔬菜名称（5个以上）		
（3）颜色色命名（6分）：红、蓝、绿、黑、白、黄 1、天空是 2、草是 3、煤是 4、少先队员的红领巾是 5、冬天下的雪是 6、麦子熟了是		
以上每项记作1分。 命名总分：		

中国知网 https://www.cnki.net

附录二：

波士顿诊断性失语症检查法（BDAE）	
0级	无意义的言语或听觉理解能力
1级	言语交流中有不连续的言语表达，但大部分需要听者去推测、询问和猜测；可交流的信息范围有限、听者在言语交流中感到困难
2级	在听者的帮助下，可能进行熟悉话题的交谈。但对陌生话题常常不能表达出自己的思想，使患者与检查者都感到进行语言交流有困难。
3级	在仅需要少量帮助下，患者可以讨论几乎所有的日常问题。但由于言语和（或）理解能力的减弱，使某些谈话出现困难或不大可能。
4级	言语流利，但可观察到有理解障碍，但思想和言语表达尚无明确限制。
5级	有极少的可分辨得出的言语障碍，患者主观上感到有点困难，但听者不一定能明显察觉到。
治疗前分级	
治疗后分级	

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

光阴荏苒，转眼三年研究生生涯即将结束，始于2018戊戌年，终于2021辛丑年，回首过往，一路走来，我要深深感谢我的父母，我的恩师，我的师姐、师兄、师妹及师弟们，是他们的扶持、教育、帮助、关心与鼓励，才让我在求知的路上踏实前行。

我要深深感谢我的恩师王祖红老师。从开题到答辩论文写作过程中对我耐心细致的指导和不懈的支持、帮助和鼓励。“高山仰止，景行行止”。师恩重如山。学生时代能遇到好老师，是人生的“三大幸”之一。在求知的道路上，我有幸能遇到那么一位好老师。好老师为何者？丰富学识，高尚人格，严而有度，爱而有嘉者也，亦我的导师祖红老师。“善为师者，既美其道，又慎其行”，王老师不但教以我学识，更以高尚的品行教育我，引导我。

我要深深感谢我的父母。父爱如山，母爱如水。是他们给予我生命，并用高尚的人格开导了我人生的第一课，他们的言传身教，培养了我勤奋、努力、进取和诚实、守信、仁爱的思想品性；他们的支持与鼓励，是我求知前行的动力和源泉。

我要深深感谢我的师姐、师兄、同门、师妹、师弟们。人生相遇是一种缘分，谢谢你们每一个人在我开展课题研究过程中对我的帮助。

我要感谢云南中医药大学和昆明市中医医院。正因为有了你们，我才拥有了聆听恩师教诲，目睹学者大师风采，奠定我医者人生之基的机会。在以后的工作和生活中，我将一直牢记“崇德和合，博学敦行”的校训，不断努力，为母校争光。

我还要感谢我的好朋友们和我的男朋友，一直以来的支持和陪伴。

滴水之恩，当涌泉相报。人生路上，我将以恩师为范，以师姐师兄们为榜，奋发进取，努力前行，用“悬壶济世”之医者仁心践行医生之职业操守，回报社会，回报父母，回报我的恩师和一切关心我、爱护我，给予我帮助与支持的朋友们！

范梦蝶

中国知网 https://www.cnki.net